



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN IPCN BULAN JANUARI
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

I. SDM

1.1 Ketenagaan (Kebutuhan dan Distribusi Tenaga, Kualifikasi Tenaga).

1.1.1 Kebutuhan SDM dan Distribusi Tenaga.

Tabel 1.1.1 Kebutuhan dan distribusi tenaga.

Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	Januari 2026	Kebutuhan	
IPCO	1	1	0	
IPCN	1	1	0	1 purna waktu
IPCLN	17	17	0	IPCLN merangkap kegiatan pelayanan pasien
Maternitas	1	1	0	
Gizi	1	1	0	
IPSRS & K3RS	1	1	0	
CSSD	1	1	0	
Laundry	1	1	0	
Cleaning Service	1	1	0	
Petugas Kamar Jenazah	1	1	0	
Laboratorium	1	1	0	
IFRS	1	2	0	1 Gudang Farmasi, 1 Pelayanan Farmasi
Instalasi Rekam Medis	1	1	0	
Asuransi Center	1	1	0	
Radiologi	1	1	0	

1.1.2 Pemenuhan Kualifikasi SDM.

Tabel 1.1.2 Pemenuhan Kualifikasi SDM.

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPC N	IPC N lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
IPCO : dr. Aida M, Sp. OG	Dokter	Dokter	+	-	+	-	-	-	
IPCN: Sherly Rosita, S. Kep, Ns	S1	S1	+	-	+	+	-	-	
Rismaya Felantri A, S. Kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPC N	IPC N lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
Neni N, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Eko Pambudi, Amd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Yuni Novita, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Raysa R, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Purwinda Respati P, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Tri Ani Darma, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	Sudah pelatihan eksternal PPI dasar
Resa Novitasari, Amd.Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Anis N. S. Kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Tatik Widayati, S. Kep. Ns	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Uswatun Chorida, AMd. Keb	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Laras Wieny, Amd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	Sudah pelatihan eksternal PPI dasar
Diyah Purwanti, S. kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Wahlah, S. Kep. Ns	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Lusianah Nurul I, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Ns. Firda Ayu Maghfiro, S. Tr. Kep	Min. D3	D4	+	-	-	-	-	-	

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi						Keterangan
	Standar	Kondisi bulan ini	PPI dasar	PPI lanjut	PPI starkes	IPC N	IPC N lanjut	PPI TOT	Isi yg berhubungan dg PPI
Tiara Anggita Putri, S. Tr. Kep. Ns	Min. D3	D4	+	-	-	-	-	-	
Trikaya Inggar Yuniar, AMd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Gizi : Veni Lestari, Amd .GZ	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
IPSRS & K3RS : Faisal, S.KM	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
CSSD: Taufan, Amd. Kep	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Laundry: Nur Hidayat	Min. SMA	SMA	+	-	-	-	-	-	
Cleaning Service: Putri	Min. SMA	SMA	+	-	-	-	-	-	
Laborat: Yoga Mada A, Amd. AK	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
IFRS : Yenny Imas, S. Farm. Apt	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
IFRS : Pipin Purwa, S. Farm. Apt	Min. D3	S1	+	-	-	-	-	-	
Radiologi: Isma Mufida, AMd. Rad	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
RM: Nurmayanti Sekar Wulan, AMd. RMIK	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	
Asuransi Center: Ayu Lestari F.NR, AMd.Aktr	Min. D3	D3	+	-	-	-	-	-	

1.2 Orientasi

- Orientasi umum: Dilakukan orientasi umum dengan materi PPI dasar pada 3 orang dokter umum, 5 orang perawat, 1 analis, 2 tenaga kefarmasian, 1 security baru pada tanggal 30 Januari 2026. Pada petugas security materi PPI masih sangat awam dan perlu dipahami lebih dalam, untuk profesi lainnya lebih antusias dan dapat menjawab tanya jawab yang dilakukan saat orientasi umum.

1.3 Pendidikan dan Pelatihan

- Tidak dilakukan diklat PPI pada bulan ini.

1.4 Evaluasi Kinerja

IPCLN dan anggota komite PPI lainnya secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya, namun masih ada beberapa petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik setiap bulannya dan menunggu ditegur terlebih dahulu. Dari proses pemenuhan tugasnya diperoleh prosentase sebanyak:

Kategori Nilai	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
A/Sangat baik (91-100%)	3											
B/Baik (81-90%)	4											
C/Cukup (71-80%)	9											
D/Kurang (61-70%)	4											
E/Sangat Kurang (<61%)	7											

Analisa: Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian petugas telah menjalankan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya, namun masih terdapat proporsi yang besar pada kategori cukup dan sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas PPI belum berjalan secara optimal secara konsisten dna masih ditemukan petugas yang menjalankan tugas setelah adanya teguran atau peringatan. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada efektivitas program PPI di unit kerja, sehingga diperlukan upaya pembinaan, penguatan pemahaman tugas, serta monitoring yang berkelanjutan.

Tindak lanjut:

- Lakukan pembinaan khusus bagi petugas dengan kategori kurang dan sangat kurang.
- Terapkan sistem mentoring (petugas dengan kategori baik mendampingi yang rendah).
- Evaluasi rasio petugas–pasien, terutama saat BOR tinggi.
- Pertimbangkan redistribusi tugas atau penambahan petugas pada jam sibuk.
- Sampaikan hasil evaluasi per unit dan per individu secara berkala.
- Berikan umpan balik langsung dan jelas terhadap temuan ketidakpatuhan.
- Beri apresiasi untuk petugas/unit dengan kategori baik–sangat baik.
- Terapkan teguran bertahap bagi yang tidak menunjukkan perbaikan.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

[illegible]

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

3.1 Hasil Surveilans HAls dan Mutu PPI

Tabel 3.1 Hasil Capaian Surveilans PPI di RS Prima Husada Malang Tahun 2026

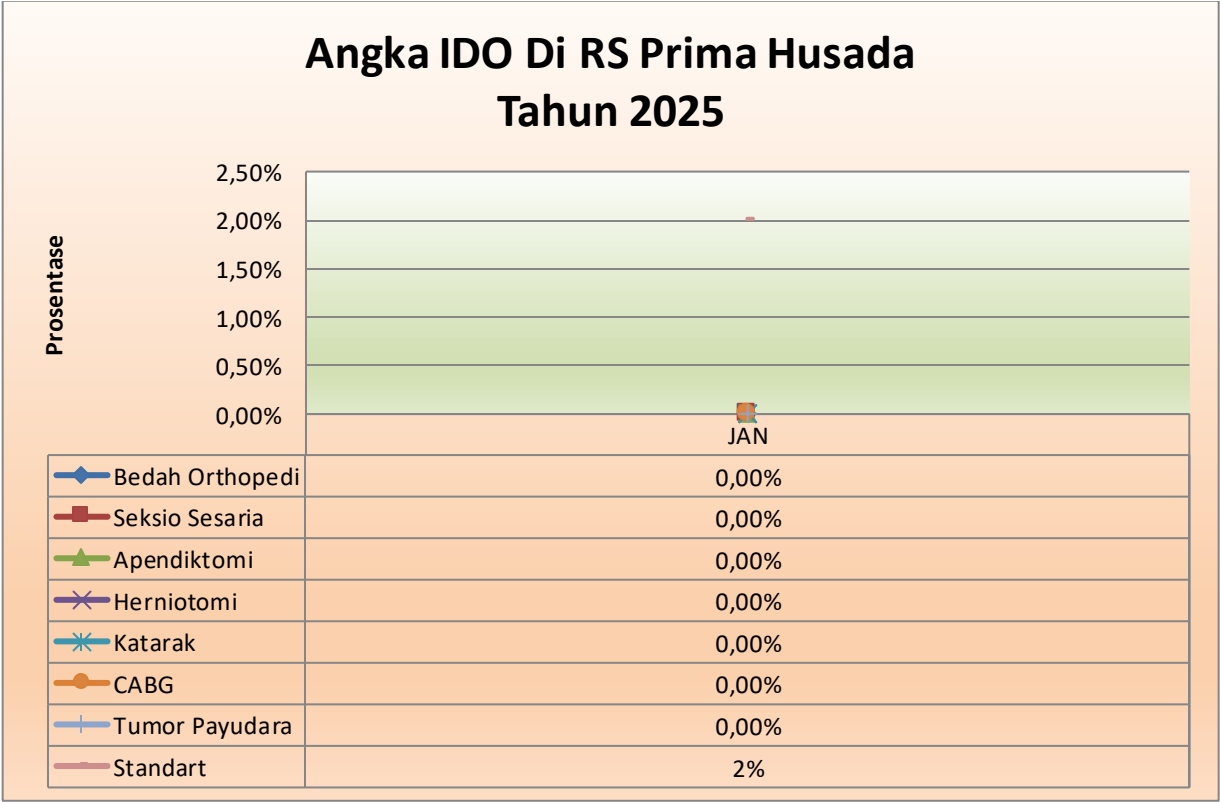
[illegible]

3.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

Tabel 3.1.1 Data IDO berdasarkan jenis Tindakan operasi sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

SSI 2026	Bedah Orthopedi	Seksio Sesaria	Apendiktomi	Herniotomi	Katarak	CABG	Tumor Payudara
Januari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	88	73	6	15	46	-	13
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

Gambar 3.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) pada semua operasi di RS Prima Husada:



Analisa	Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0%, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus IDO.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.				
Tindakan yang dilakukan	• Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI. • Monitoring kepatuhan Hand hygiene. • Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Penguatan surveilans pasca operasi $\leq$ 30 hari ($\leq$ 90 hari pada implan).	• Mempertahankan angka IDO $\leq$2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.	• Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.	• Penguatan surveilans pasca operasi $\leq$30 hari ($\leq$90 hari pada implan). • Menjalankan audit bundle SSI dengan baik. • Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis. • Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.	• Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.	• Monitoring bulanan
• Pertahankan bundle IDO berjalan dengan baik.	• Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	• Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Monitoring bulanan

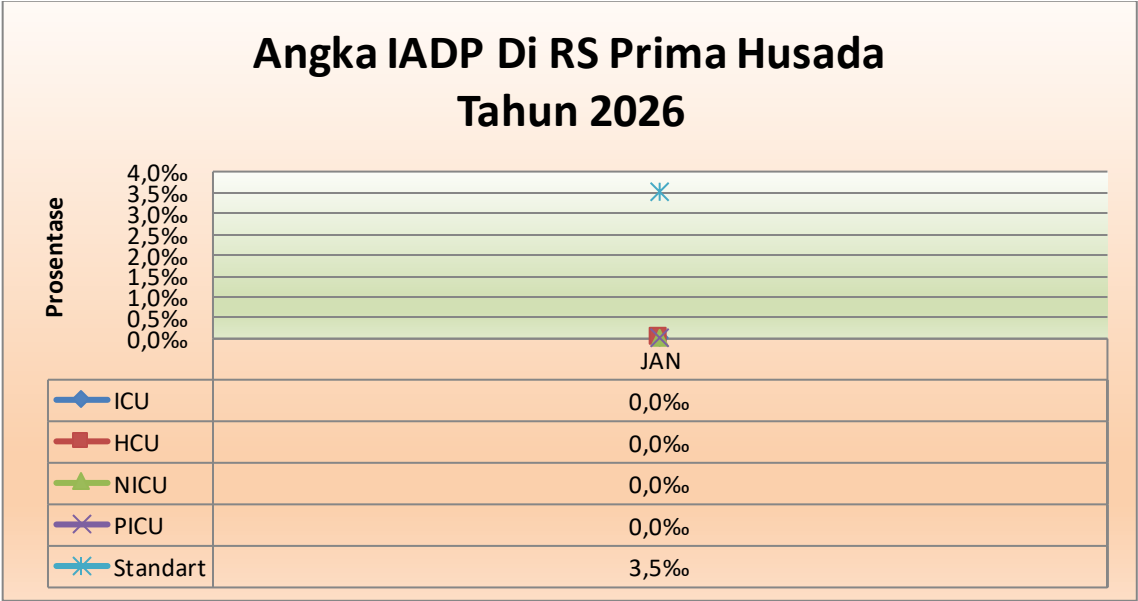
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diet tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/PCN	• Monitoring bulanan
---	---	--	---	---	--

3.1.2 IADP

Tabel 3.1.2 Data IADP berdasarkan ruang sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

IADP 2026	ICU	HCU	NICU	PICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

Gambar 3.1.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak ada tindakan pemasangan CVC.
Masalah saat ini	• Tidak terjadi IADP
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi IADP

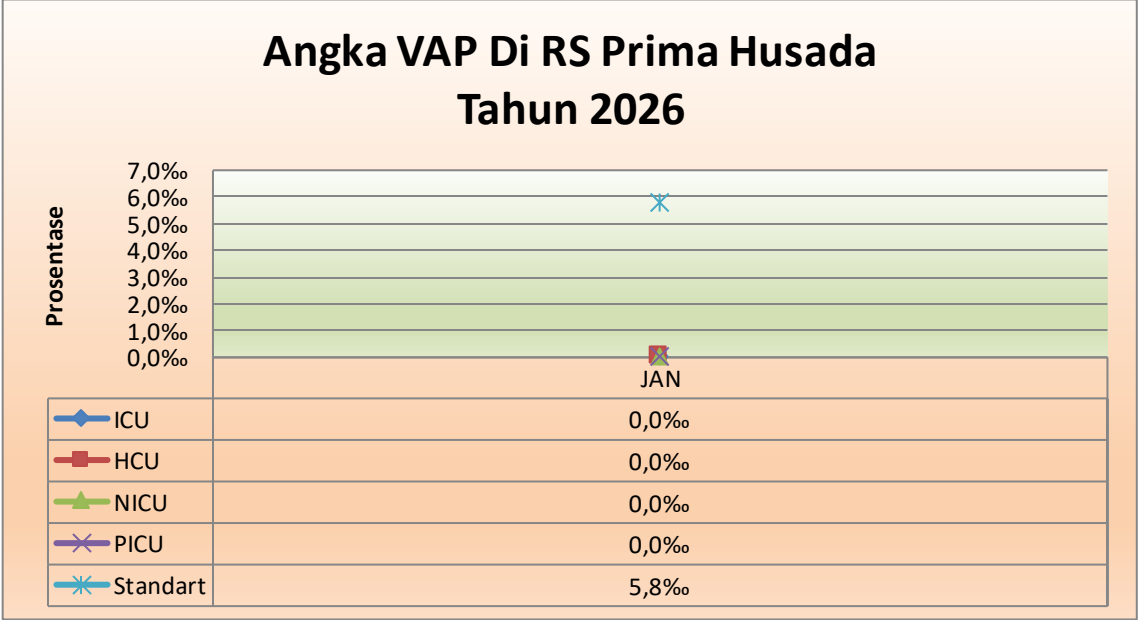
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. • Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Melakukan monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	• Pasien dengan pemakaian CVC.	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCPN	• Satu bulan

3.1.3 VAP

Tabel 3.1.3 Data VAP berdasarkan ruang sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

VAP 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	86	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

Grafik 3.1.3 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 86 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. • Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. • Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. • Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. • Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

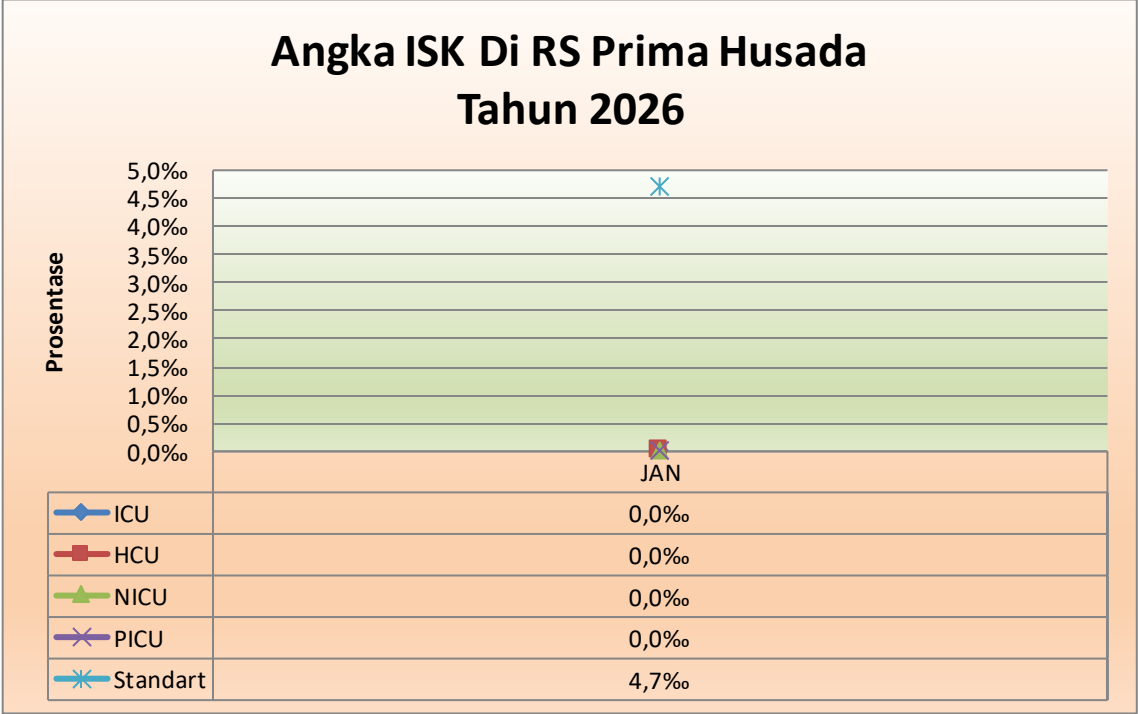
• Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	• Pasien yang terpasang ventilator mekanik	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. • Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. • Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. • Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. • Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPC�	• Satu bulan
--	---	--	---	--	--

3.1.4 ISK

Tabel 3.1.4 Data ISK berdasarkan ruang sesuai pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

ISK 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	188	40	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

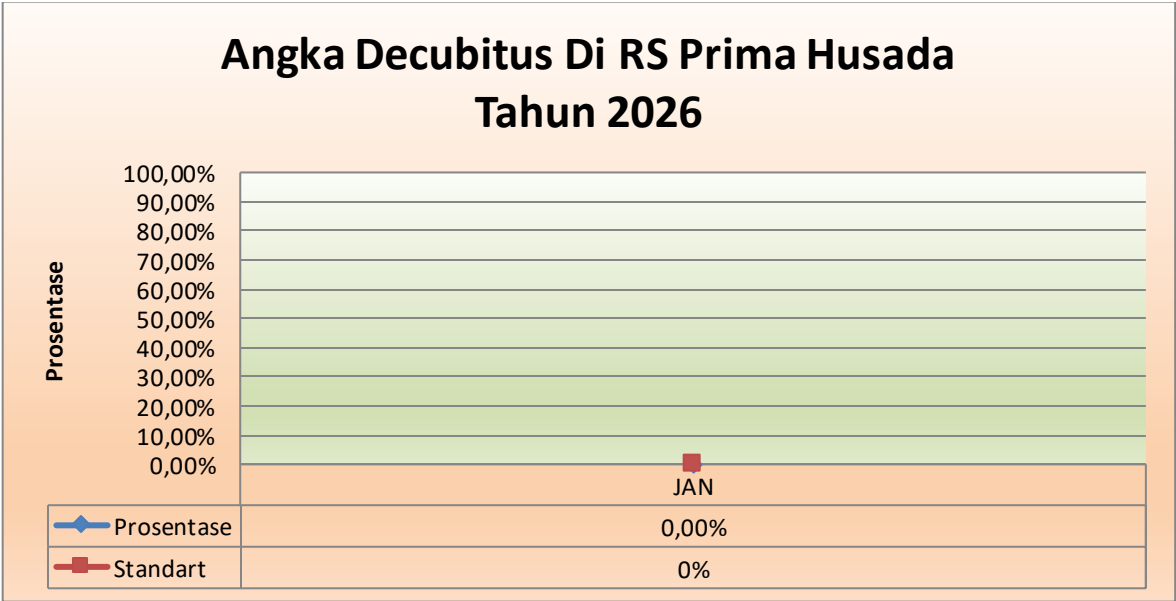
Gambar 3.1.4 Grafik Angka Infeksi Saluran kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1278 hari lama pemakaian kateter pasien.
Masalah saat ini	• Tidak terjadi ISK
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi ISK
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. • Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.

Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. - Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPC�	Satu bulan

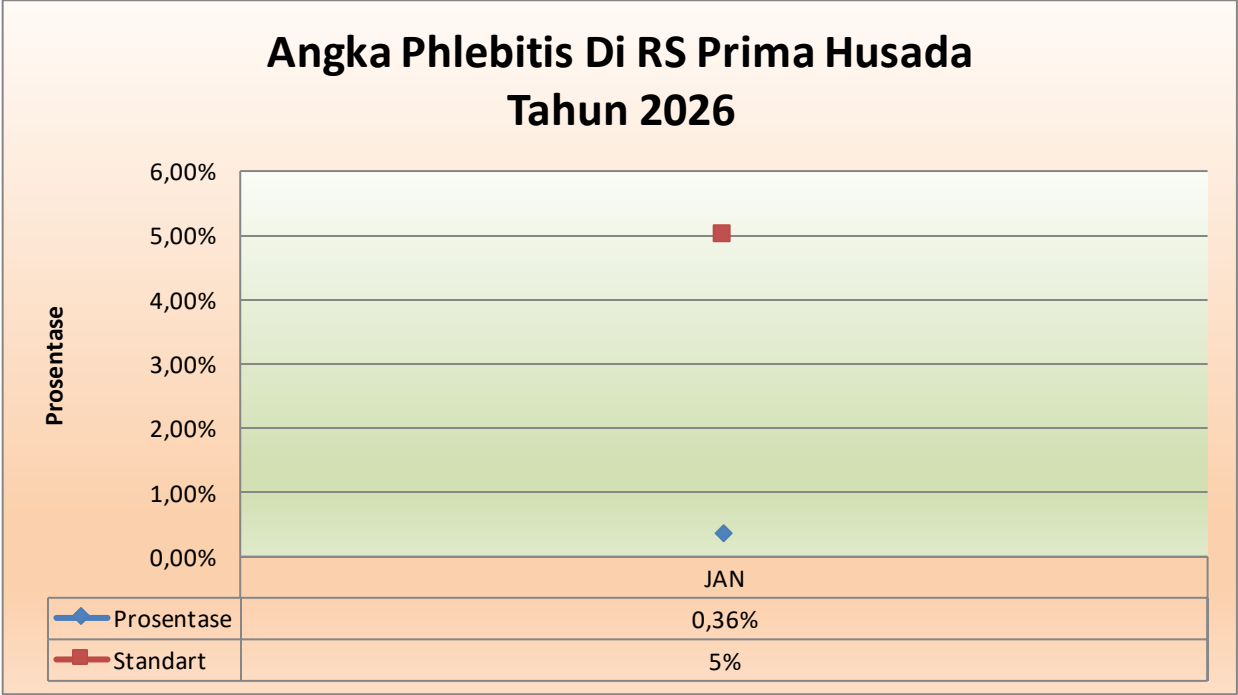
3.1.5 Decubitus
Gambar 3.1.5 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 51 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. • Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	• Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain • Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

3.1.6 Phlebitis

Gambar 3.1.6 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



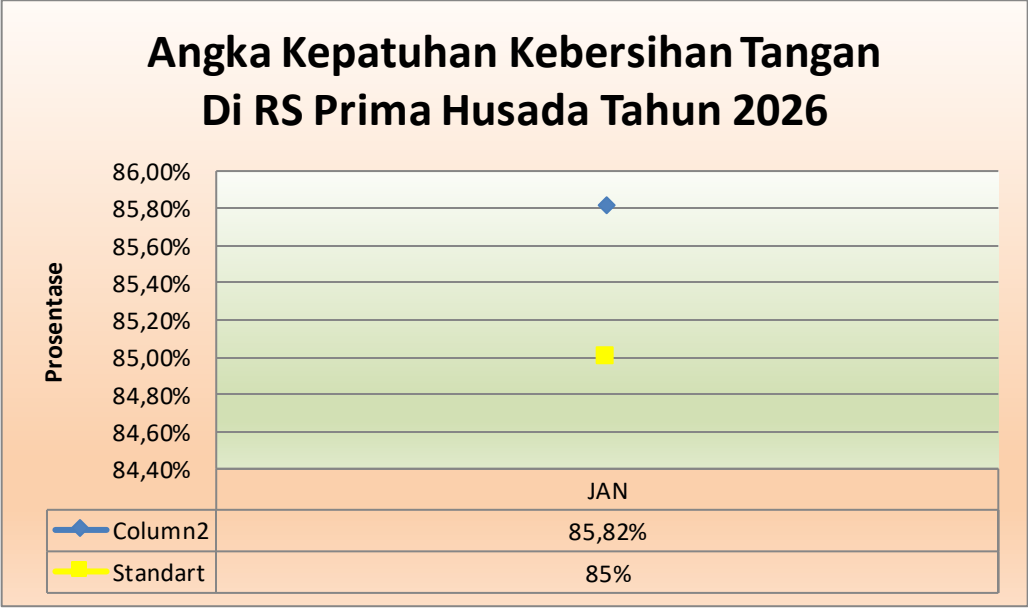
Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2815 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,36%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan Desember berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis peningkatan pada perawatan infus, serta pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Dari data yang diperoleh terdapat 10 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif tanpa pengenceran optimal, pemberian transfusi darah.
---------	---

	Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	• Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. • Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Permasalahan sebelumnya	• Pengenceran obat kurang optimal dan kurang terkontrol di ruangan. • Teknik pemasangan infus yang tidak seragam, serta perawatan yang kurang optimal.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. • Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. • Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. • Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. • Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Perbaiki kepatuhan bundle phlebitis.	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Pasien yang terpasang infus	• Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. • Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. • Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. • Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. • Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. • Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. • Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

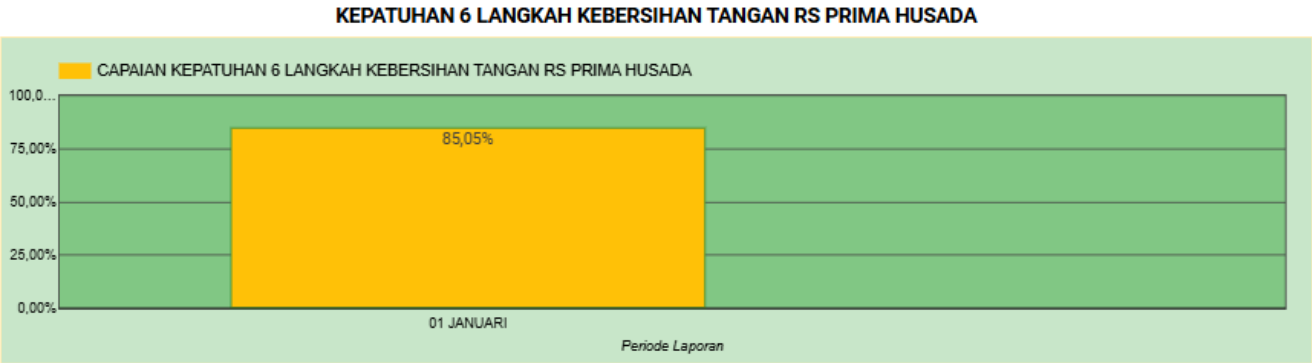
			• Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.		
• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	• Perawat/bidan • Apoteker	• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. • Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. • Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	• Perawat /Bidan • Apoteker • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan
• Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Perawat/bidan	• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). • Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus. • Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. • Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Tiga bulan

3.1.7 Kebersihan Tangan

Gambar 3.1.7 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (Hand Hygiene)

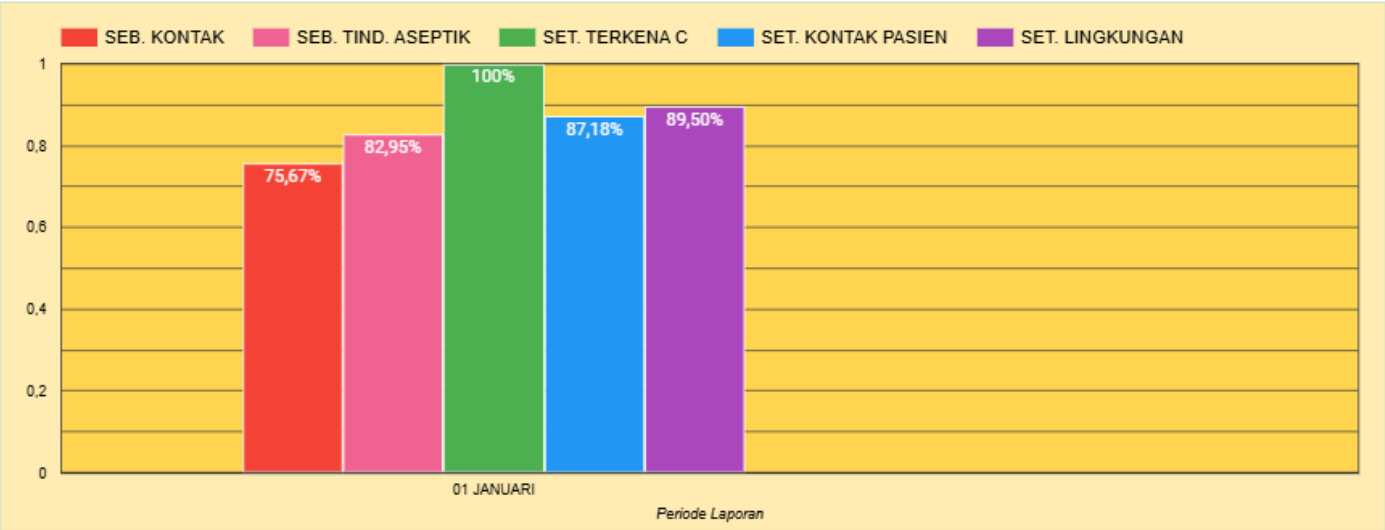


Gambar 3.1.7.1 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan Tangan (Hand Hygiene)



Gambar 3.1.7.2 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

Kepatuhan Berdasarkan Five Momen Kebersihan Tangan RS Prima Husada

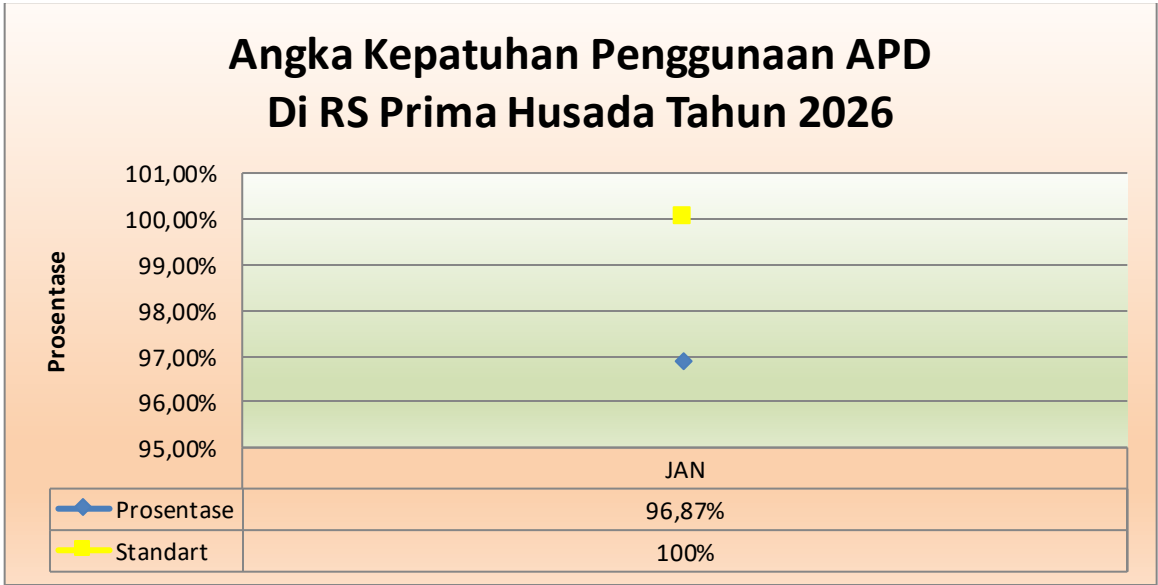


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2025 berada sedikit di atas standar (selisih +0,82%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan, yang berarti ada sedikit peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhdap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 85,05%. Nilai ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (Desember 2025: 84,61%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan peningkatan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, bukan hanya peningkatan frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.
Masalah saat ini	• Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna.

	• Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. • Menerapkan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kebersihan tangan.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. • Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. • Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. • Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPC�	• Satu bulan

• Lanjutkan audit kepatuhan secara acak dan supervisi pengamatan rutin.	• Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	• Petugas kesehatan	• Melakukan audit mendadak (spot check) agar kebiasaan cuci tangan terpantau tanpa pengaruh pengawasan langsung. • Kepala ruangan dan IPCN melakukan pemantauan harian terutama pada shift pagi & sore. • Memberikan feedback cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian.	• Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan
---	---	---	---	--	--

3.1.8 Kepatuhan APD
Gambar 3.1.8 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

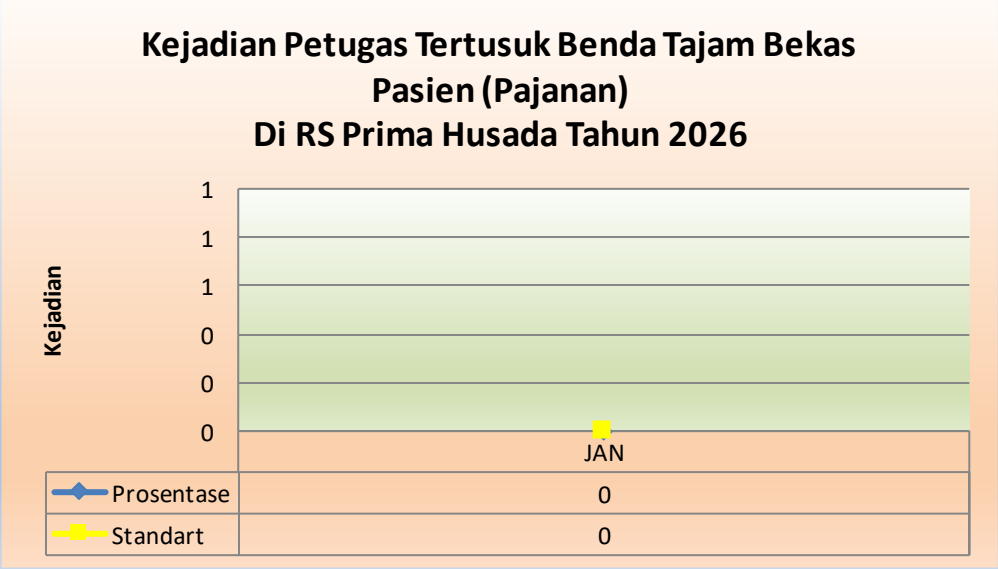


Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 96,87%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak lengkap atau tidak sesuai indikasi. Terjadi peningkatan pada bulan ini, menunjukkan adanya: perbaikan perilaku penggunaan APD, meningkatnya kesadaran staf, atau pengaruh dari pengawasan dan edukasi
---------	--

	langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Meskipun meningkat, nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan berlebihan menggunakan APD. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.				
Masalah saat ini	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakkonsistenan penggunaan APD antar shift dan antar unit. • Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	• Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Penguatan budaya keselamatan dengan melakukan briefing harian dengan pesan wajib: “APD lengkap sebelum kontak dengan pasien atau cairan tubuh.” • Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. • Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

			• Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. • Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. • Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Audit kepatuhan harian per shift, IPCN/kepala ruangan/IPCLN/PJ Shift melakukan audit: pagi, sore, malam, minimal 3–5 observasi per shift. Catat petugas dengan angka kepatuhan rendah untuk ditindaklanjuti pada evaluasi kinerja.		
--	--	--	---	--	--

3.1.9 Kejadian Petugas tertusuk benda Tajam
Gambar 3.1.10 Garfik Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).



Analisa	Tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas.				
Masalah saat ini	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. • Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. • Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. • Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. • Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	• Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. • Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. • Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. • Monitoring teknik recapping tutup jarum.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

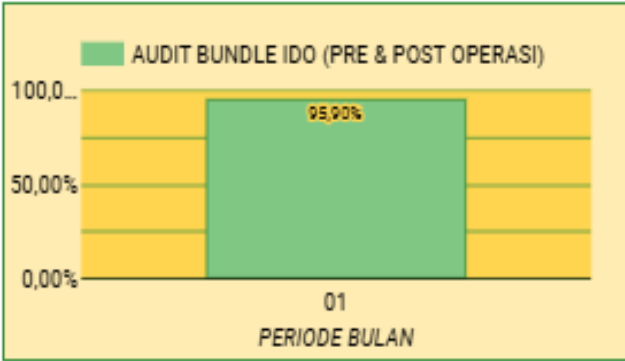
3.2 Hasil Audit Bundle HAI's

3.2.1 Audit Bundle IDO

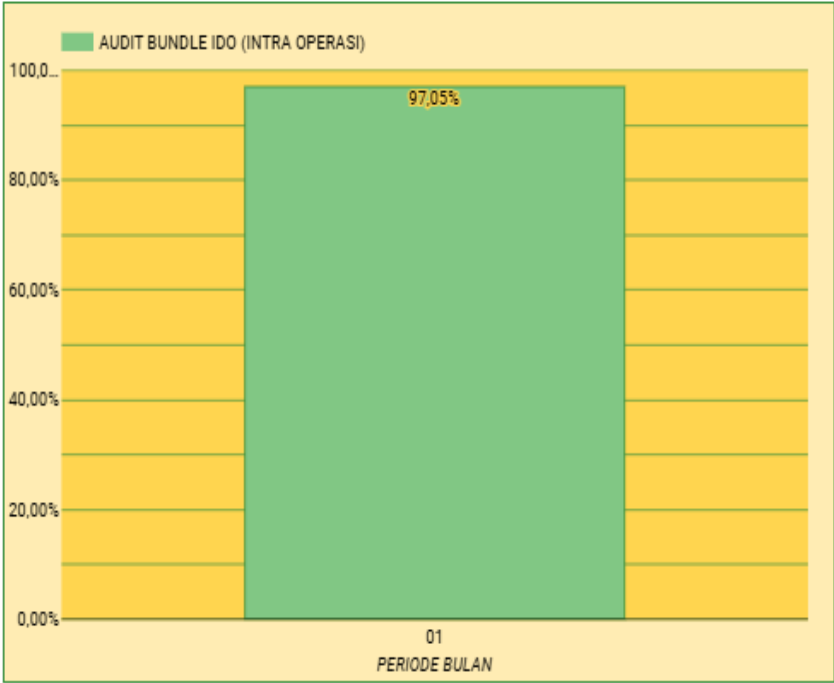
a. Gambar 3.2.1 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Daerah Operasi (IDO) Pre dan Post Operasi dari masing-masing unit:



IRNA 2A



b. Gambar 3.2.1.1 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Daerah Operasi (IDO) Intra Operasi di IKO:
AUDIT BUNDLE IDO (INTRA OPERASI)



Tahun: 2026 (1) ▾

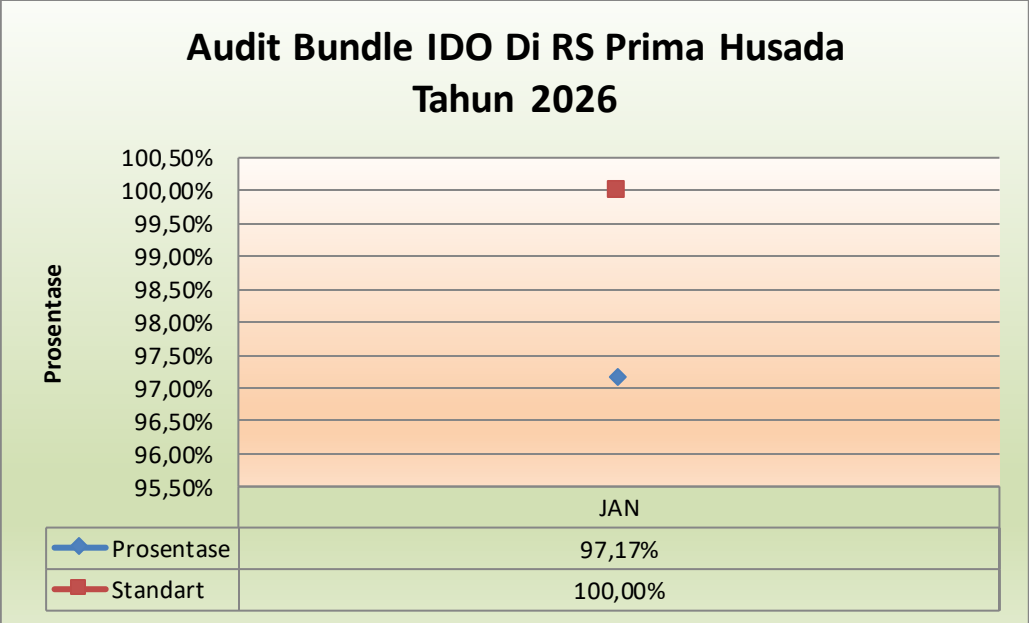
PERIODE BULAN: 01 (1) ▾

Keterangan: +

Periode Bulan:

- 01 = Januari
- 02 = Februari
- 03 = Maret
- 04 = April
- 05 = Mei
- 06 = Juni
- 07 = Juli
- 08 = Agustus
- 09 = September
- 10 = Oktober
- 11 = November
- 12 = Desember

c. Gambar 3.2.1.2 Grafik Rata-rata Hasil Audit Bundle Infeksi Daerah Operasi (IDO):

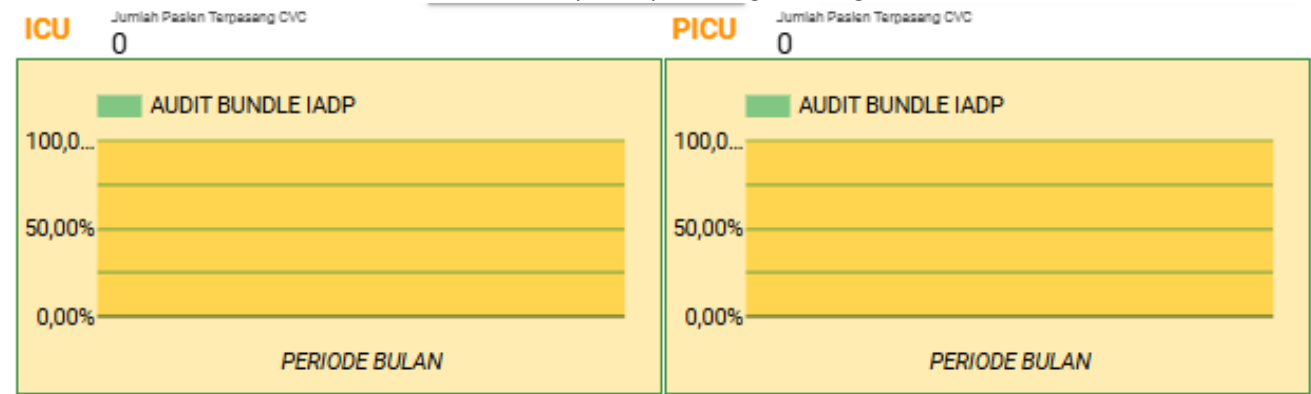


Kegiatan Pokok	Audit bundle IDO				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle IDO pada bulan ini secara keseluruhan yaitu 97,17%. Dimana pada bulan ini audit bundle IDO pre operasi mengalami peningkatan yang banyak pada anjuran pasien untuk mandi antiseptic/sabun sebelum dilakukan operasi namun belum bisa terlaksana dilapangan dikarenakan pasien dengan post KLL atau terdapat luka terbuka takut lukanya perih terkena air meskipun sudah dianjurkan untuk diseka saja. Tetapi pada kondisi pasien yang operasi loadingan dari awal perencanaan operasi sudah diberikan edukasi untuk mandi sebelum proses operasi berlangsung. Untuk pasien yang operasi cyto yang tidak sempat dilakukan mandi/seka namun sudah rutin selalu dilakukan desinfeksi area sekitar luka.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Penerapan bundle IDO.	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam	Kepatuhan audit bundle IDO petugas	Menganjurkan petugas pre operasi untuk tetap melakukan mandi antiseptic / air sabun dengan cara diseka jika pasien dalam kondisi urgent.	- Perawat /Bidan - Dokter	Satu bulan

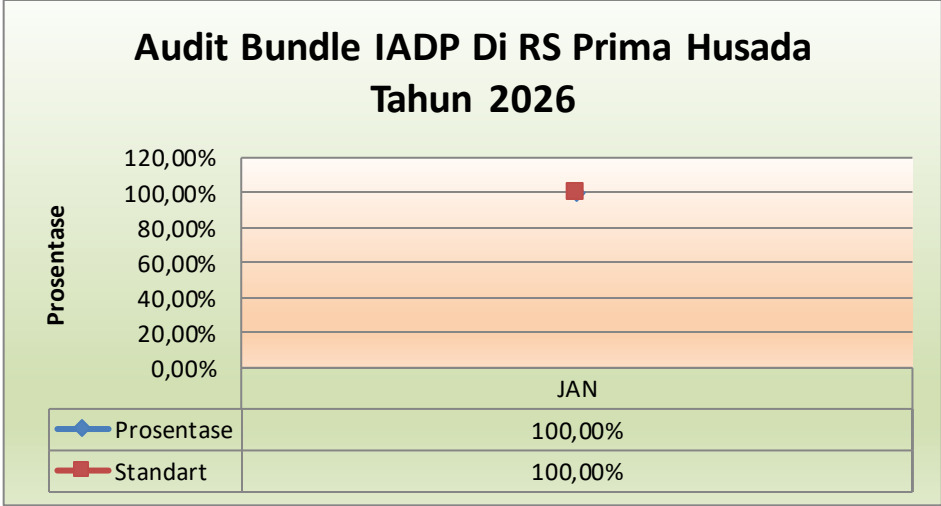
	menjalankan bundle IDO.		• Menyarankan untuk tim yang sudah selesai melakukan tindakan pada pasien untuk menjauhi meja operasi untuk meminimalkan resiko infeksi. • Mengingatn kembali pemakaian sarung tangan steril pada saat melakukan tindakan rawat luka. • Monitoring pembersihan alat dan ruangan IKO harus dijalankan dan ditingkatkan. • Koordinasi dengan perawat ruang bedah untuk mengingatkan prinsip steril terutama pada tim operasi untuk tetap dijalankan. • Monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas terutama pada saat akan melakukan tindakan rawat luka pasien.	• Karu • IPCLN/PCN.	
--	-------------------------	--	---	--	--

3.2.2 Audit Bundle IADP

Gambar 3.2.2 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) masing-masing unit:



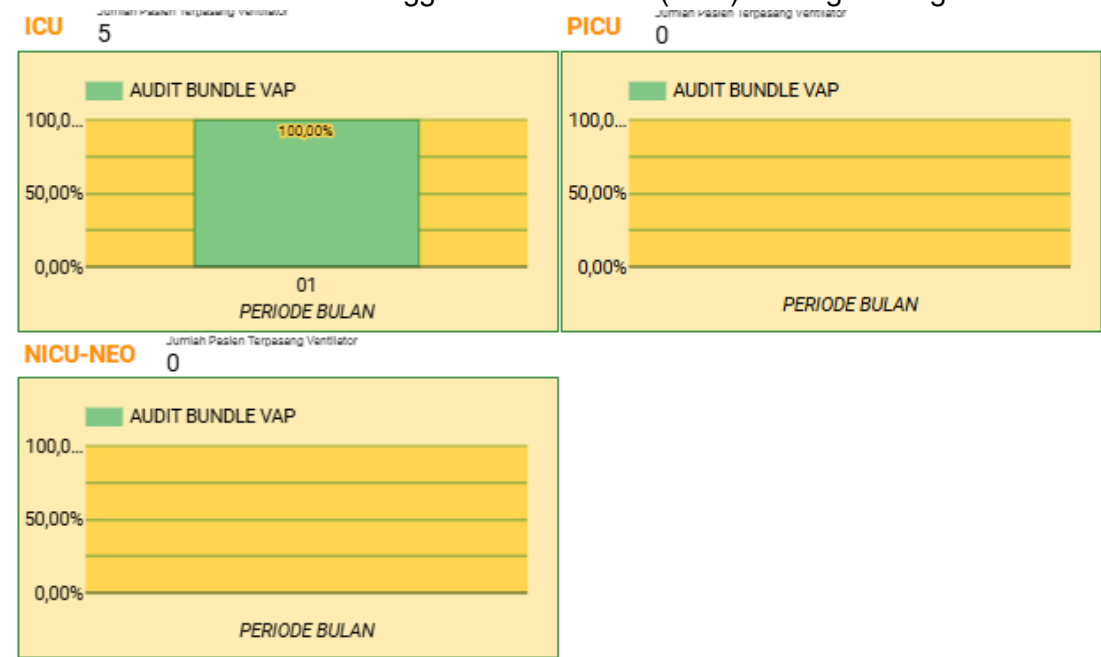
Gambar 3.2.2.1 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Aliran Darah Primer (IADP):



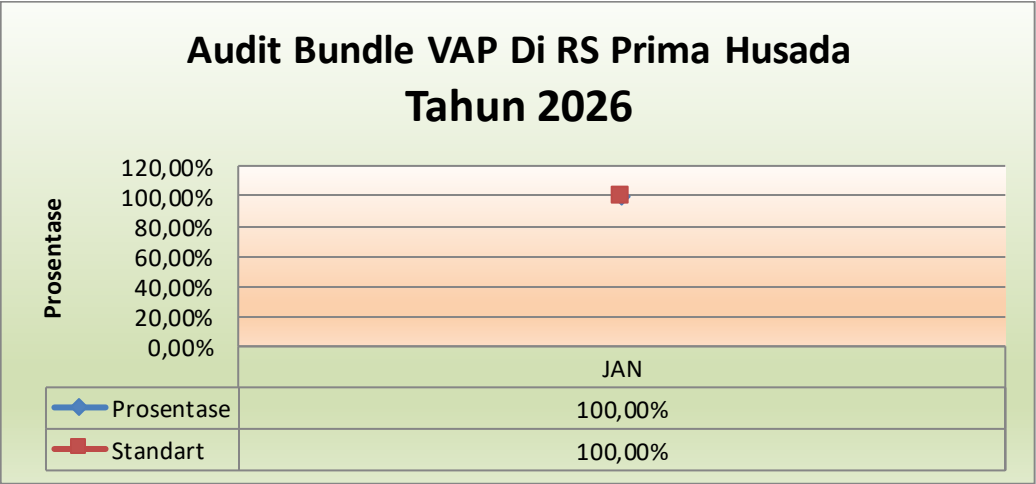
Kegiatan Pokok	Audit bundle IADP				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle IADP pada bulan ini yaitu 100%, karena tidak ada pemasangan CVC pada pasien.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring kepatuhan 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

3.2.3 Audit Bundle VAP

Gambar 3.2.3 Grafik Hasil Audit Bundle Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP) masing-masing unit:



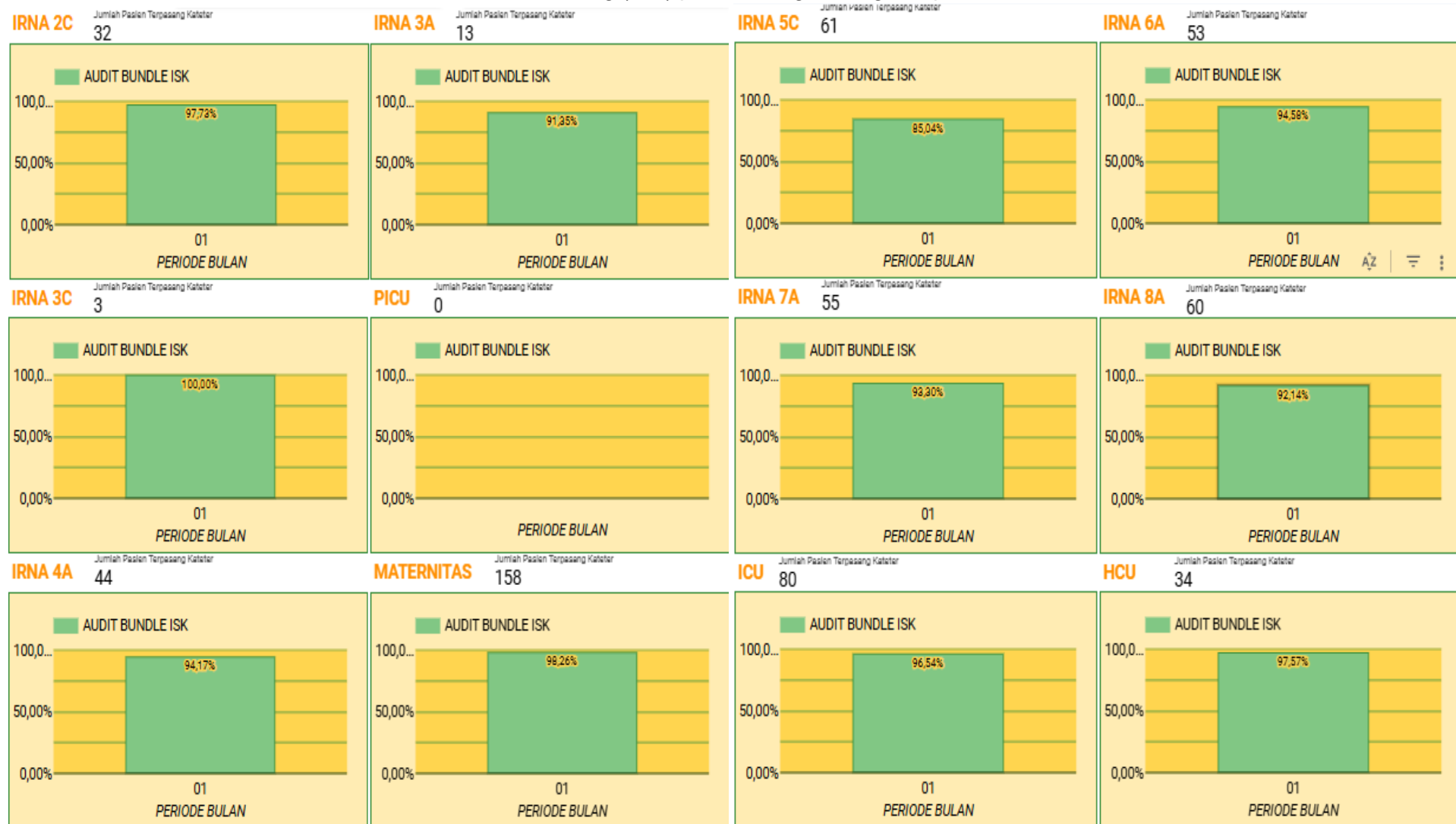
Gambar 3.2.3.1 Grafik Hasil Audit Bundle Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP):

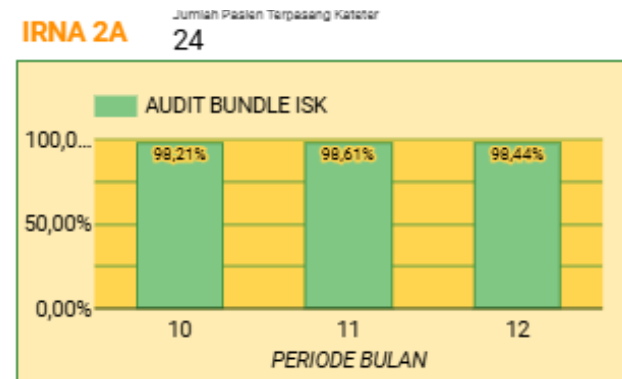


Kegiatan Pokok	Audit bundle VAP				
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle VAP pada bulan ini yaitu 100%, dimana pada bulan ini terdapat total hanya 86 jumlah hari lama pemasangan ventilator mekanik di unit ICU pada 5 orang pasien, petugas melakukan bundle VAP dengan baik.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. - Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. - Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. - Koordinasi dengan kabid keperawatan untuk mewajibkan & menertibkan oral hygiene setiap 4 jam sekali pada seluruh pasien yang terpasang ventilator mekanik dan mendokumentasikan pada Askep atau CPPT. - Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCPN	Satu bulan

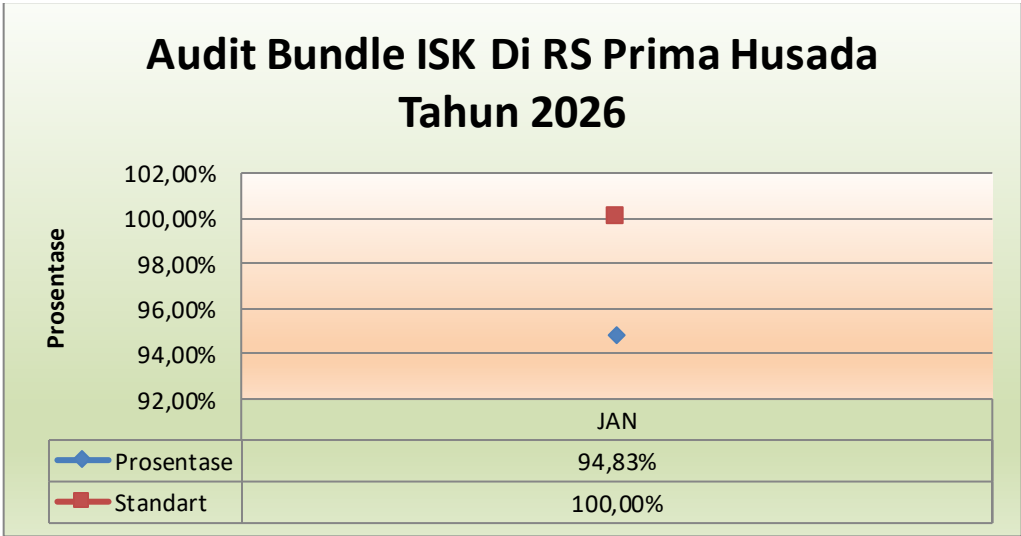
3.2.4 Audit Bundle ISK

Gambar 3.2.4 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Saluran kencing (ISK) pada masing-masing unit perawatan:





Gambar 3.2.4.1 Grafik Rata-rata Hasil Audit Bundle Infeksi Saluran kencing (ISK):



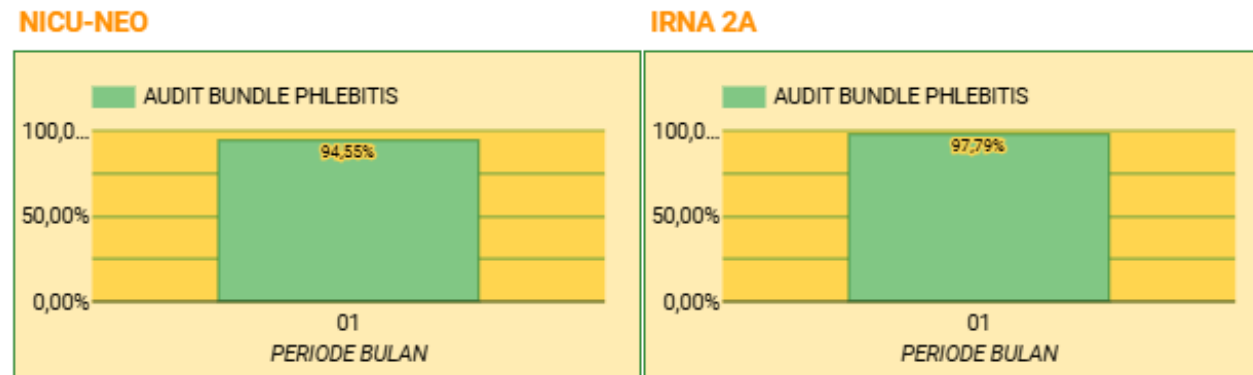
Kegiatan Pokok	Audit bundle ISK
Rincian Kegiatan	- Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit - Melakukan tindak lanjut hasil audit

Hasil Analisa	Hasil audit bundle ISK pada bulan ini yaitu 94,83%, dimana pada bulan ini terdapat pemasangan kateter di unit perawatan pasien dengan total jumlah lama hari pemasangan kateter yaitu 1278 hari (dari hasil surveilans). Dimana sebagian besar tidak patuh pada tidak dilakukannya cuci tangan sebelum tindakan karena petugas sudah langsung memakai sarung tangan, selain itu sarung tangan yang digunakan juga sarung tangan bersih yang disemprot alcohol. Teknik aseptik juga kurang dijaga dengan meletakkan bagian steril pada tempat tidur pasien meskipun sudah ada alas plastik namun plastik tidak steril bisa menyebabkan nyeri/infeksi, serta pemakaian fiksasi plester yang sering lupa tidak dilakukan.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine. - Monitoring kepatuhan 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

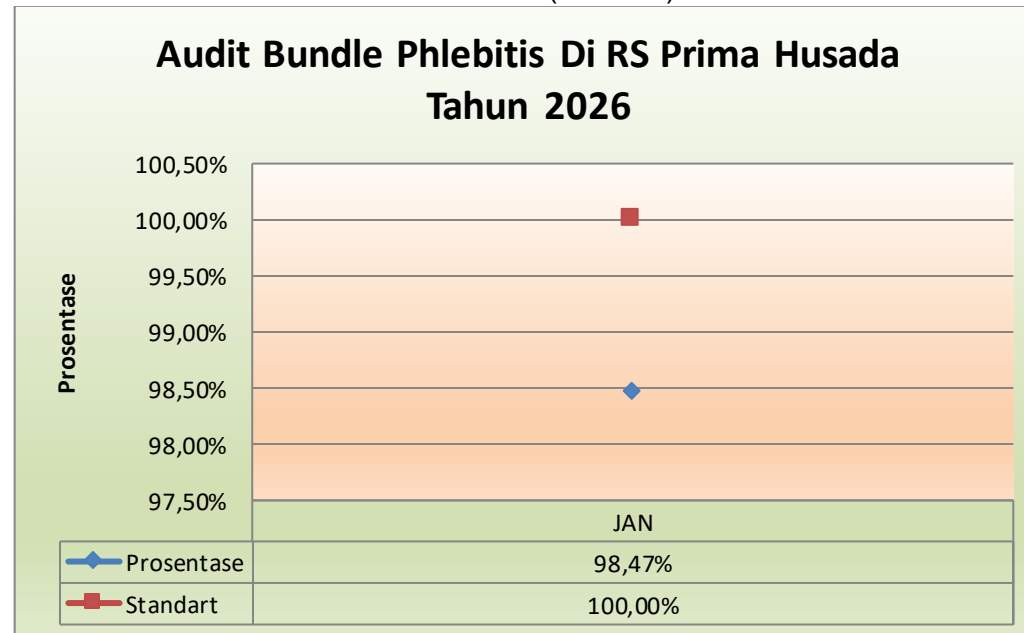
3.2.5 Audit Bundle Phlebitis

Gambar 3.2.5 Grafik Hasil Audit Bundle Infeksi Jarum Infus (Phlebitis) pada masing-masing unit:





Gambar 3.2.5.1 Grafik Rata-rata Hasil Audit Bundle Infeksi Jarum Infus (Phlebitis):



Kegiatan Pokok	Audit bundle Phlebitis				
Rincian Kegiatan	• Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit • Melakukan tindak lanjut hasil audit				
Hasil Analisa	Hasil audit bundle phlebitis pada bulan ini yaitu 98,47%, dimana pada bulan ini ketidakpatuhan terbanyak masih ada pada tidak melakukan hand hygiene saat memasang infus dan tidak dilakukannya Teknik aseptik pada saat akan melakukan penyuntikan pada selang infus. Selain itu, pada saat melakukan injeksi melalui selang infus juga masih ditemukan petugas yang tidak melakukan desinfeksi pada tubing selang terlebih dahulu. Pemilihan area pemasangan infus sudah mengalami peningkatan, maintenance luka tusukan infus juga mulai dilakukan oleh petugas, sehingga jika terjadi phlebitis bisa diketahui lebih dini.				
RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	• Monitoring kepatuhan 5 moment cuci tangan. • Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. • Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. • Monitoring penyuntikan yang aman. • Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. • Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. • Mengingatkan kembali petugas untuk menyiapkan minimal 1 kapas alcohol swab saat menyiapkan injeksi pada wadah injeksi masing-masing pasien agar tidak lupa untuk melakukan desinfeksi tubing selang sebelum injeksi melalui selang infus.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

3.3 Fasilitas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

3.3.1 Fasilitas Kesehatan

Tabel 3.3.1 Fasilitas Kesehatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan Bulan Januari 2026
1	Pemeliharaan alat	-
2	Kalibrasi	-
3	Penambahan alat	-
4	Monitoring Kesehatan	a. Pemenuhan gizi karyawan tetap dilakukan dengan pemberian makan pada karyawan setiap Jumat pagi dan pemberian extra fooding pada petugas radiologi. b. Pada bulan ini juga masih berlangsung pemberian buka puasa bagi karyawan yang menjalankan ibadah puasa sunnah. c. Pada bulan ini tidak dilakukan pemberian vaksin maupun vitamin pada karyawan. d. Dilakukan pemeriksaan rectal swab karyawan pada bulan ini sebanyak 10 orang penjamah makanan.
5	Pembangunan dan renovasi	Dilakukan renovasi tembok retak di tembok area belakang gedung D selama 3 hari.

3.3.2 Keselamatan Kerja (Manajemen Resiko)

Tabel 3.3.2 Kejadian Keselamatan Kerja (Manajemen Resiko)

No	Jenis Kejadian	Ringkasan
1	Tidak ada kejadian terkena benda tajam (pajanan)	-

3.3.3 PKRS

Tabel 3.3.3 Kegiatan PKRS Komite PPI RS Prima Husada Malang

No	Kegiatan PKRS	Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan
1	Kegiatan sosialisasi dan edukasi kelompok pasien dan keluarga	- Kegiatan edukasi kelompok pada bulan ini memenuhi 8x edukasi. - Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang PPI (kebersihan tangan, etika batuk, PHBS) kepada pasien, keluarga dan pengunjung secara berkala oleh anggota Komite PPI dengan koordinasi dengan Tim PKRS. Edukasi kelompok paling banyak dilakukan di ruang koridor rawat inap dan ruang tunggu rawat jalan.

Laporan Sosialisasi/Edukasi Kelompok PPI

Jumlah peserta yang didaftarkan

82

82

Periode pela... (1) -

Nama Unit

Tahun: 2026 (1) -

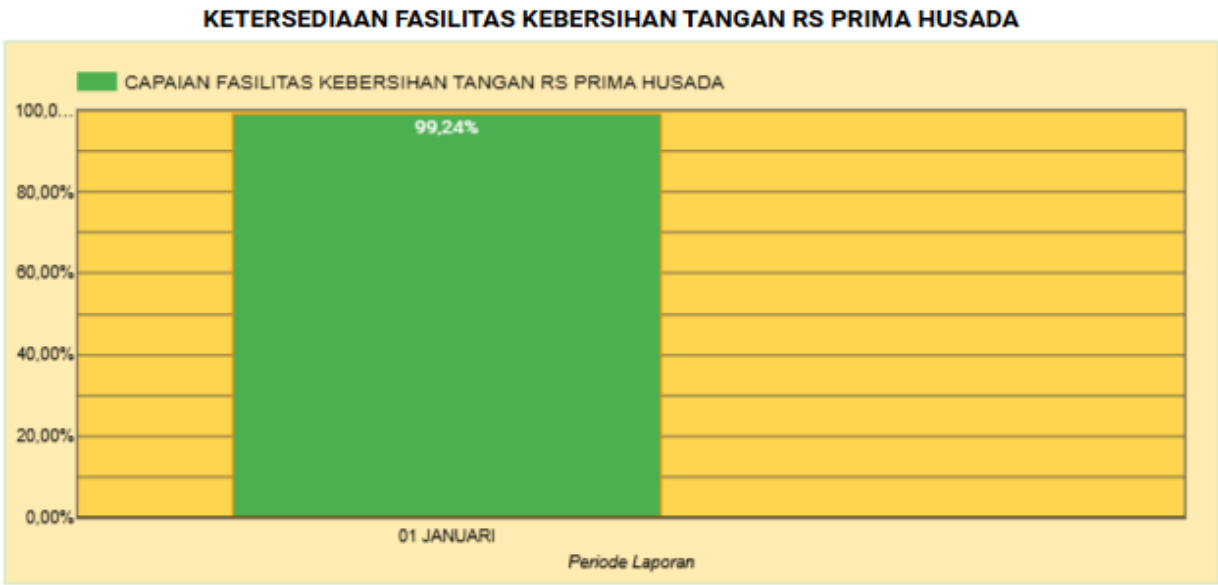
Period...	Tangg...	Nama U...	Nama Ed...	Judul/Topik...	Ju...	Foto 1	Foto 2	Daftar Hadir
1. 01 JANUARI	17 Jan 2025, 11.20.00	IRNA IC	Oky	persiapan lula desain operasi Kode/Nomor Lainnya : 80055	5			
2. 01 JANUARI	23 Jan 2025, 08.30.00	MATERIN AS	Ana	PPH Kode/Nomor Lainnya : URM/202	5			
3. 01 JANUARI	26 Jan 2025, 08.15.00	IRNA IC	Afni	Phis Kode/Nomor Lainnya : URM/2024	5			
4. 01 JANUARI	26 Jan 2025, 15.00.00	IRNA IC	Oky	teknik betuk efektif Kode/Nomor Lainnya : PR001	5			

2	Edukasi melalui media audiovisual.	- Dilakukan edukasi kelompok dengan penayangan video edukasi cuci tangan di ruang tunggu poli dan farmasi dan sampai saat ini masih terus dilakukan dengan jeda waktu pemutaran video sekitar 30 menit sekali. (25 x tayang /hari) Namun saat ini berkurang karena adanya tambahan video edukasi lainnya menjadi 60 menit sekali penayangan atau 12x /hari.
3	Edukasi pasien di RM	- Edukasi ini masih belum berjalan rutin dengan baik, penggunaan ERM terkait lembar edukasi membuat keterisian lembar edukasi terkait hand hygiene dan etika batuk berkurang. Saat dikonfirmasi ke pasien (3 dari 5 pasien memang belum diberikan edukasi, sisanya hanya diingatkan untuk sering melakukan cuci tangan dengan melihat stiker HH yang ditempel di bed).
4	Kegiatan sosialisasi dan edukasi PPI kepada staf	- Dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang PPI (kebersihan tangan, etika batuk pemakaian APD, dan pemilahan sampah) kepada sesama staf oleh anggota Komite PPI pada saat jam dinas, kegiatan edukasi oleh PPI berjalan di unit-unit pelayanan. Dokumentasi kegiatan dikoordinasikan juga dengan tim PKRS.
Bukti dokumentasi sosialisasi:		- https://sites.google.com/view/komite-ppi-rs-prima-husada/kegiatan-ppi/sosialisasi-ppi/sosialisasiedukasi-kelompok

IV. Monitoring Dan Evaluasi

4.1 Monitoring Supervisi
(Laporan hasil supervise disertai bukti dokumentasi dapat diakses melalui: <https://sites.google.com/view/komite-ppi-rs-prima-husada/laporan/laporan-monitoring-supervisi-ppi>)

4.1.1 Fasilitas Kebersihan Tangan
Gambar 4.1.1 Grafik capaian fasilitas kebersihan tangan di RS Prima Husada

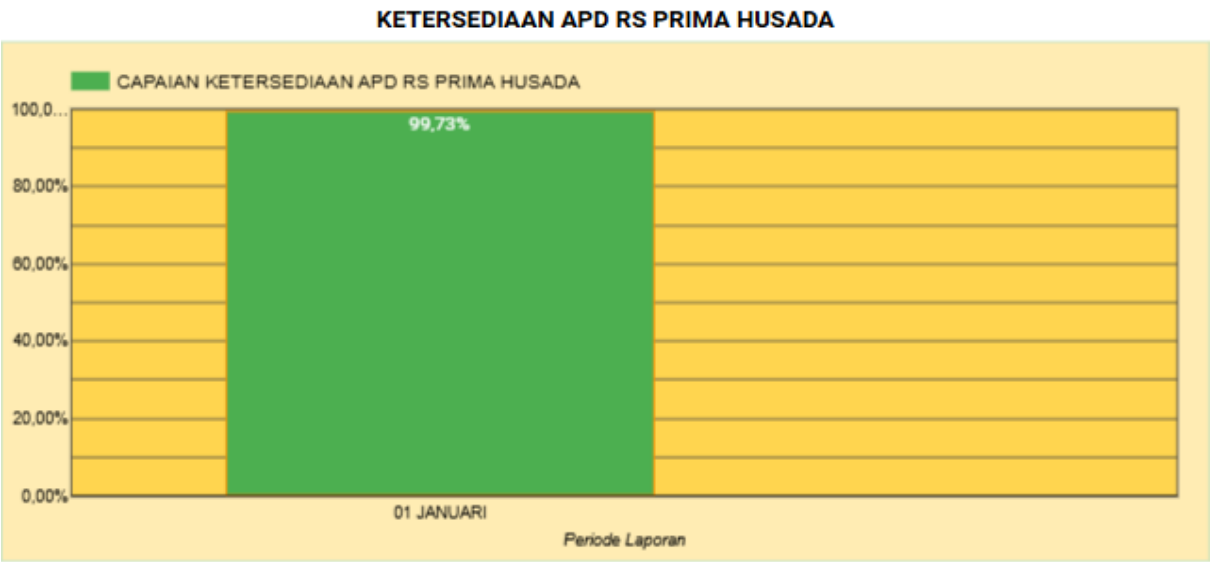


Kegiatan Pokok	Audit supervise fasilitas kebersihan tangan.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	Ketersediaan fasilitas kebersihan tangan mencapai 99,24%. Kebersihan wastafel dan kelengkapan fasilitas seperti handsoap, tissue, dan tempat sampah mengalami peningkatan.

	• 4 temuan supervisi pada sampling ruangan yang berbeda ditemukan ketidaklengkapan fasilitas diantaranya yaitu botol handsoap yang tidak tersedia di wastafel karena digunakan petugas untuk ke toilet, 2 temuan botol handrub yang tidak tersedia di bed pasien karena sedang dibersihkan dan diisi ulang. • Selain itu, 5 temuan stiker hand hygiene yang rusak dan memang waktunya untuk diganti di bed pasien.
RTL	• Tingkatkan capaian dan monitoring ketersediaan fasilitas kebersihan tangan di unit. • Menambahkan botol handsoap pada tiap wastafel di area umum. • Melakukan koordinasi juga dengan CS unit untuk memiliki stok botol handrub kosong di tiap unit sebagai cadangan jika ada handrub yang habis dan harus diisi ulang. • Mengorderkan kembali stiker cuci tangan yang rusak dan segera memperbarui dengan stiker yang baru. • Koordinasi dengan petugas tim umum untuk melakukan pembersihan area wastafel dan bracket handrub serta ikut mengingatkan petugas lainnya jika meletakkan barang-barang diatas wastafel.

4.1.2 Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)

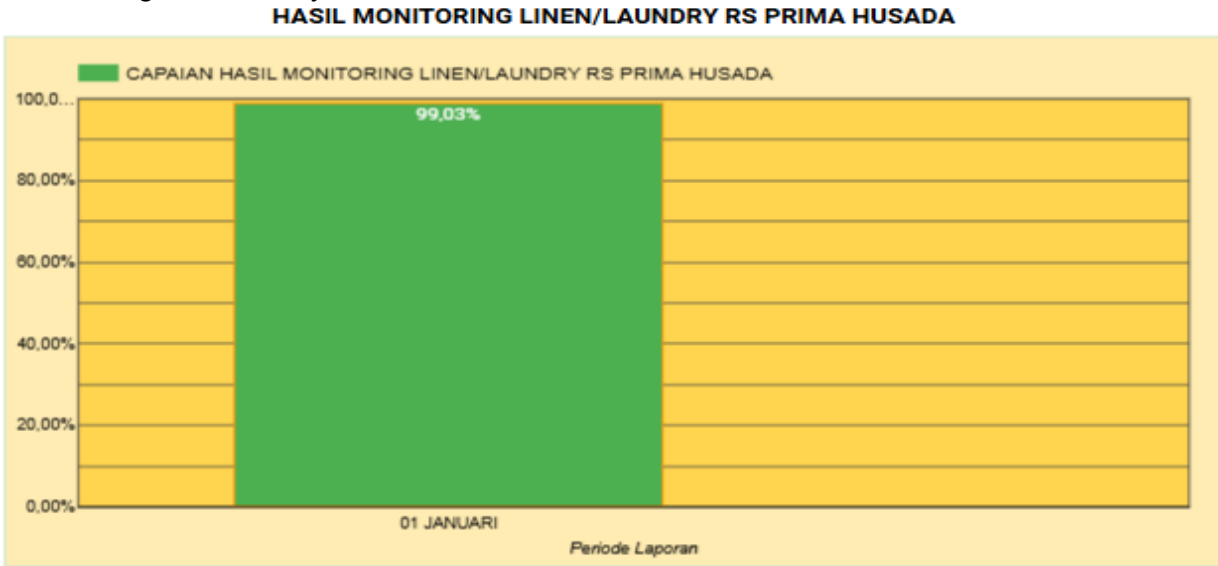
Gambar 4.1.2 Grafik capaian ketersediaan alat pelindung diri (APD) di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi ketersediaan dan kesesuaian APD di Unit.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Ketersediaan dan kesesuaian APD pada bulan ini mencapai 99,73%. Ketersediaan APD berkoordinasi dengan IFRS dan gudang untuk melakukan pengadaan dan melakukan floor stok setiap akhir bulannya. • Rumah sakit tidak pernah mengalami kekurangan APD, hanya saja petugas unit yang terkadang tidak memperhatikan stok minimal yang ada di unitnya. • Ditemukan 1 dari hasil supervisi pada sampling unit yang berbeda ditemukan ketersediaan APD sepatu boot tersedia namun petugas tidak menggunakannya dan memakai sandal jepit di CSSD.
RTL	• Tingkatkan capaian dan monitoring ketersediaan APD di unit agar tidak sampai menimbun atau kehabisan APD. • Koordinasi dengan petugas CSSD untuk memanfaatkan APD yang sudah tersedia dengan baik untuk keselamatan kerja.

4.1.3 Monitoring Linen/Laundry

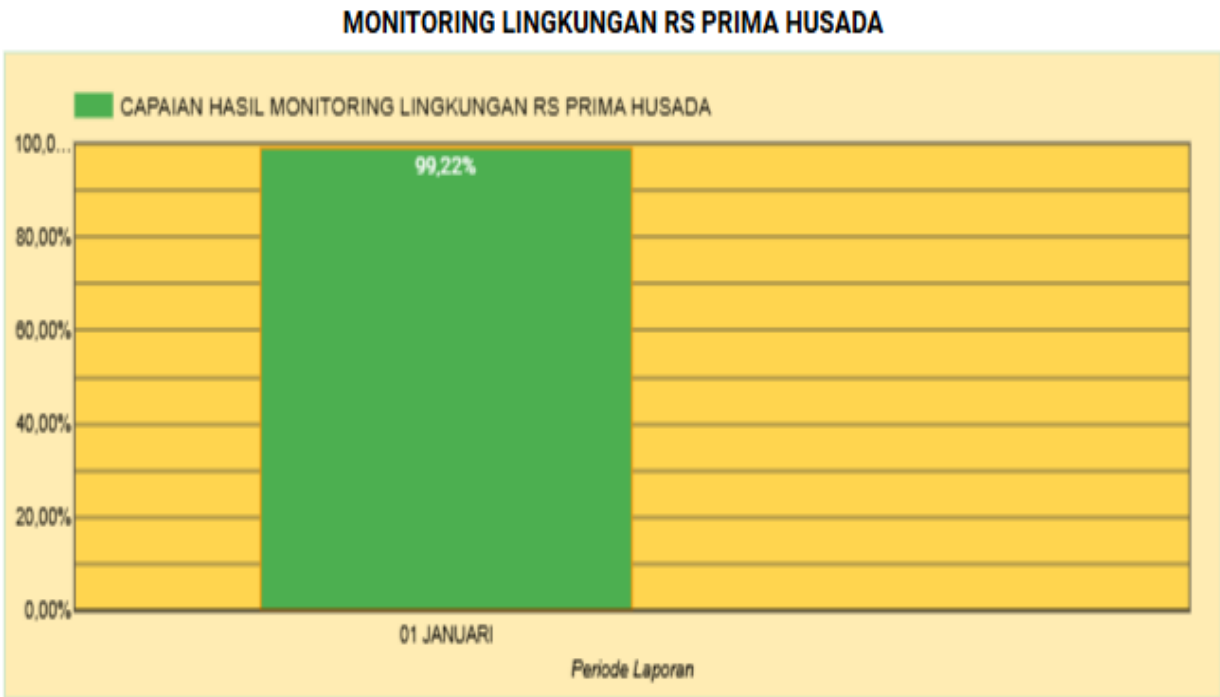
Gambar 4.1.3 Grafik capaian monitoring linen/laundry di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi pengelolaan Linen/Laundry.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Pengelolaan linen sudah berjalan dengan capaian prosentase 99,03%. • Ditemukan pencatatan serah terima linen bersih mulai berjalan dengan baik karena sudah ada akses ipad dari rumah sakit. • Peletakkan linen kotor yang masih tergantung ujung linennya diluar tong sudah mulai mengalami perbaikan di unit, namun masih ditemukan sebanyak 3x di ruangan rawat inap. • Ruang laundry sudah rutin sekali dibersihkan terutama lantai dan permukaan mesin cucinya, namun hanya focus area lantai saja kurang perhatikan troli dimana masih ditemukan sisa kertas/tissue yang ikut tercuci. • Troli Linen masih sering ditemukan kotor ada bekas tissue/kertas dan beberapa sudah berlubang kain pelapisnya.
RTL	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervisi berkala oleh kepala unit/PJ shift setiap shiftnya untuk menertibkan petugas ruangan yang tidak tertib meletakkan linen kotor. • Mengingatkan tim laundry untuk tetap membersihkan keseluruhan area laundry supaya tidak beresiko debu menumpuk. • Evaluasi kembali proses pembersihan troli dan koordinasi dengan Karu laundry dan bagian IPSRS untuk perbaikan kain pelapis laundry dengan mengganti lapisan stainless supaya lebih mudah dibersihkan.

4.1.4 Monitoring Lingkungan

Gambar 4.1.4 Grafik capaian monitoring lingkungan di RS Prima Husada

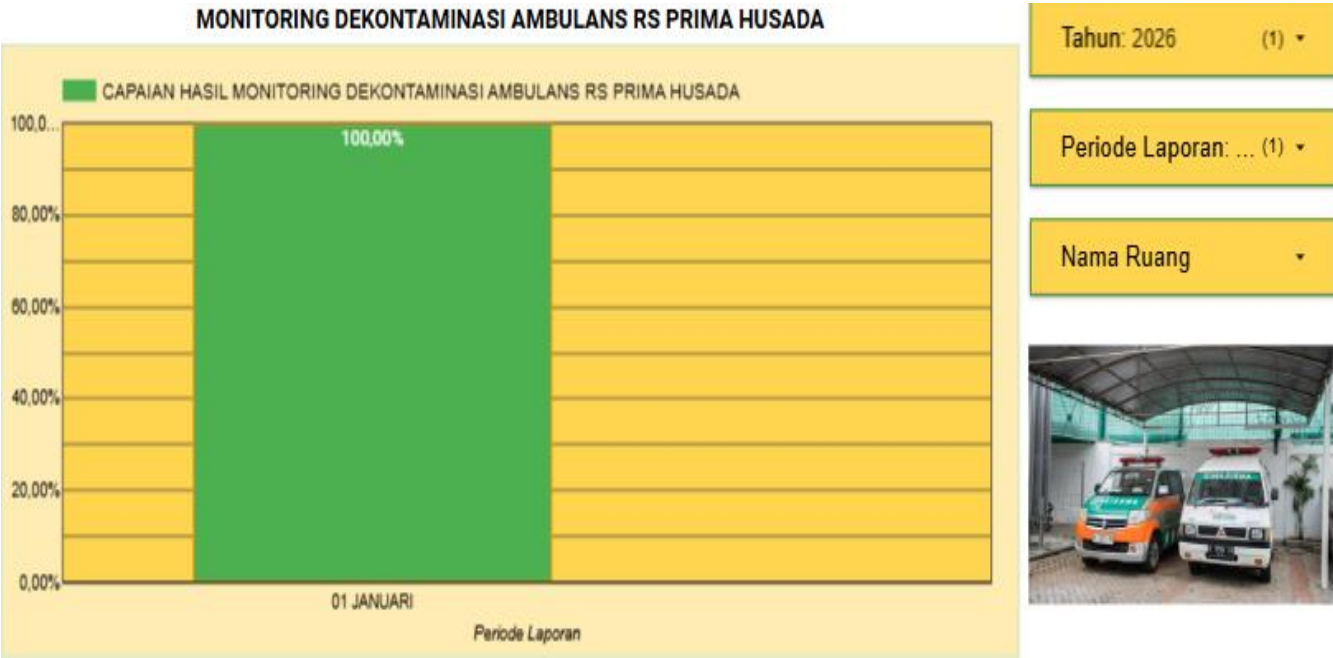


Kegiatan Pokok	Audit supervisi pengendalian infeksi lingkungan.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Prosentase kebersihan lingkungan RS secara keseluruhan yaitu 99,22%. • Kebersihan ruangan masih belum dilakukan menyeluruh dengan baik. Ditemukan di ruangan recovery room set alkes (monitor ecg) yang masih berdebu. Area bed head pasien masih berdebu, termasuk kerangka bed pasiennya. List jendela ruang dan exhaust fan juga sedikit berdebu. Untuk kamar mandi, masih ditemukan kotor. Serta masih ditemukan semut diarea sekitar ruang perawatan.

	• Ditemukan area Lorong yang jarang dilewati kurang rutin dibersihkan dan tatakan dispenser ruangan yang berisi air beresiko sarang jentik nyamuk.
RTL	• Tingkatkan capaian dan melakukan koordinasi dengan Karu dan tim CS untuk menjaga lingkungan tempat kerja nya selalu bersih dan rapi. • Koordinasi dengan CS untuk membersihkan area bed head pasien rutin terutama pada saat pasien pulang dan area sudut-sudut ruang. Lakukan monitoring pada saat ada pasien pulang. • Koordinasi dengan CS untuk membersihkan area yang terdapat semut dan mencari sumbernya. • Minta petugas unit jaga saat itu untuk mengambil kanebo dan segera membersihkan peralatan yang terlihat kotor dan mengedukasikan untuk melakukan pembersihan sebelum dan setelah melakukan tindakan. • Menyampaikan pada kepala ruang untuk lebih memperhatikan ruangnya dan meningkatkan rasa empati pada unitnya sendiri agar lebih peka lagi. • Koordinasi dengan CS unit untuk sering memeriksa tatakan dispenser supaya tidak jadi sarang jentik. • Matras penunggu pasien wajib dibersihkan kembali setelah digunakan dan koordinasi untuk melakukan permintaan perbaikan untuk matras yang rusak/mengelupas.

4.1.5 Dekontaminasi Ambulans

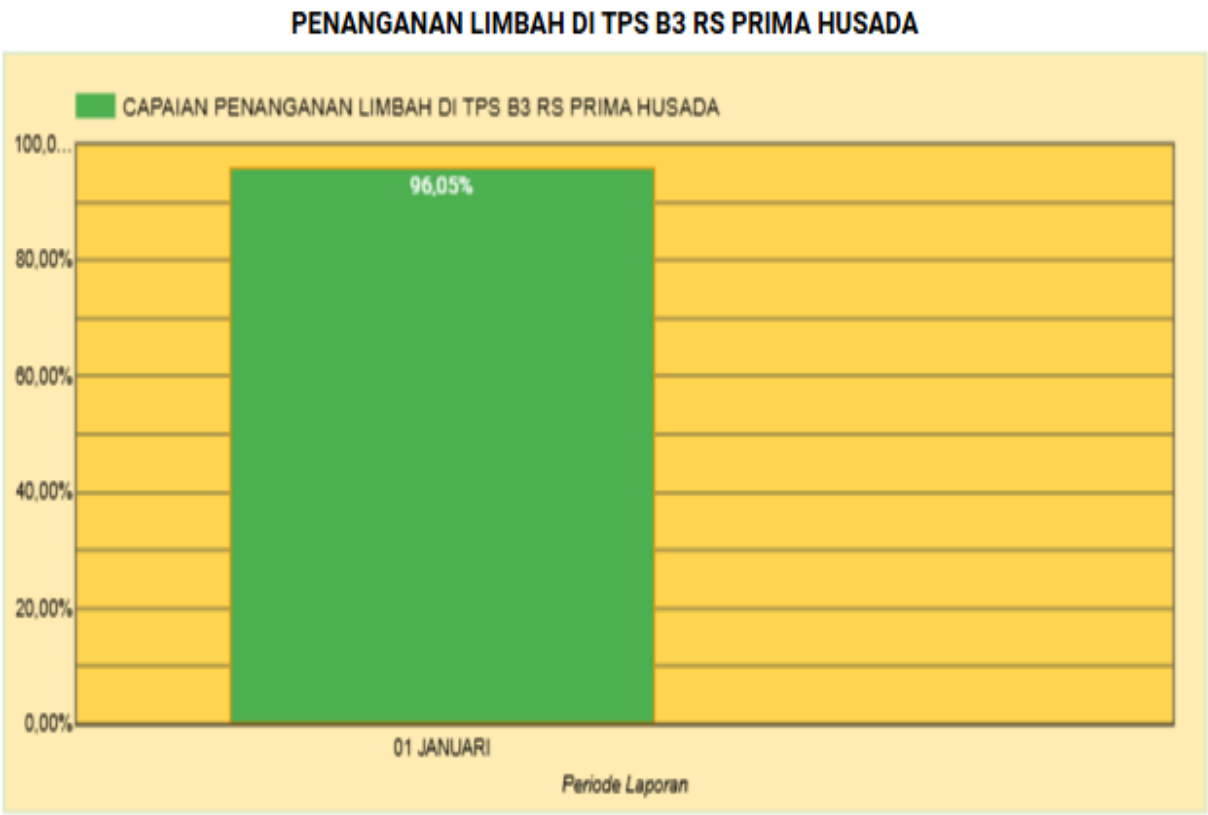
Gambar 4.1.5 Grafik capaian dekontaminasi ambulans RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi dekontaminasi mobil ambulans.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	- Prosentase audit dekontaminasi mobil ambulans sebesar 100%. Dekotaminasi mobil ambulance sudah dilakukan setiap hari dan dibersihkan setelah penggunaan ambulans estafet selesai digunakan menghantarkan pasien. - Tidak ditemukan tumpahan darah/cairan tubuh di dalam ambulans.
RTL	Pertahankan capaian dan lanjutkan melakukan audit dekontaminasi mobil ambulans, monitoring catatan perawatan mobil ambulans.

4.1.6 Penanganan Limbah Di TPS LB3

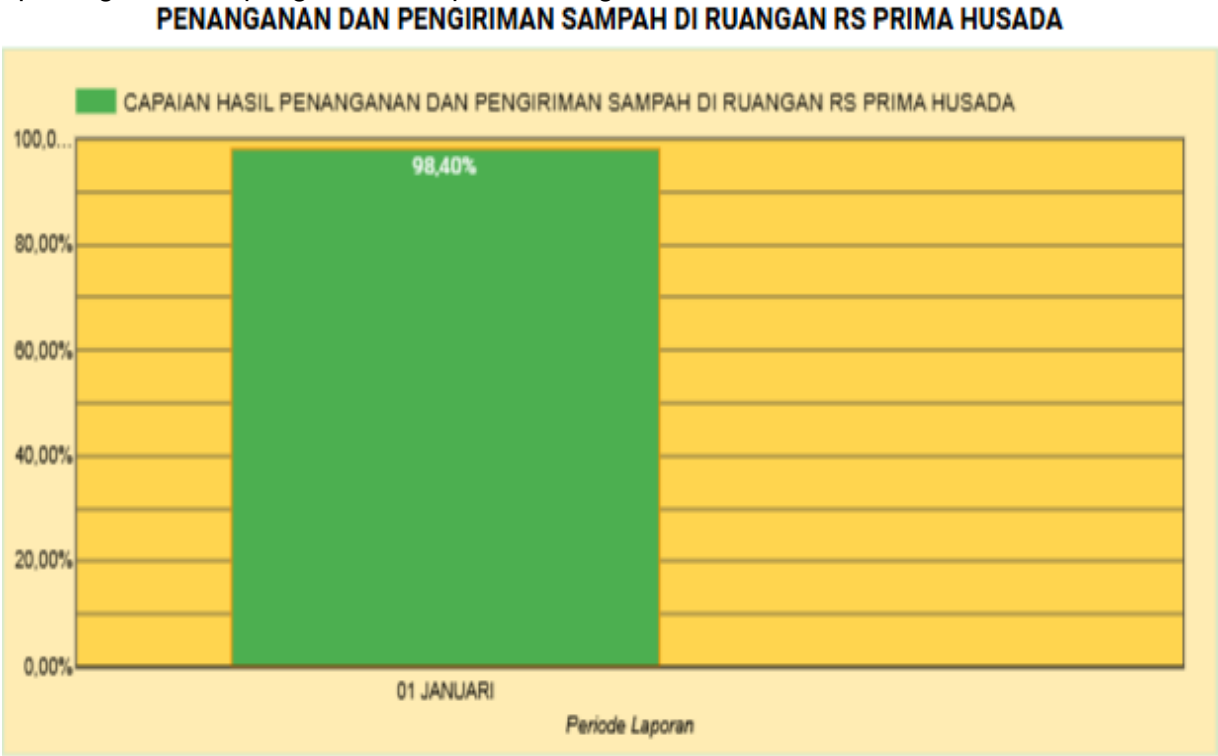
Gambar 4.1.6 Grafik capaian penanganan limbah di TPS LB3 RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi pengelolaan limbah infeksius rumah sakit (TPS B3)
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Prosentase pengolahan dan penyimpanan limbah infeksius di TPS B3 yaitu 96,05%.

	• Ditemukan area TPS B3 ada sawang-sawang didekat exhaust fan depan dan papan tutup kabel terlepas. Selain itu juga ditemukan lantai TPS B3 yang sedikit kotor. • Ekshaust fan di TPS B3 dalam tidak dinyalakan. • Pencatatan pengiriman limbah B3 masih ditemukan selisih jumlah timbangan yaitu 0,68 kg antara sampah masuk dan keluar karena adanya penyusutan ataupun pembulatan saat penghitungan, jumlah sampah masuk lebih besar dari sampah keluar. • Pengiriman limbah B3 bekerja sama dengan pihak ke 3 dengan control dari petugas sanitasi dan PPI dilakukan setiap 2 hari sekali kecuali hari besar & Minggu. Rutin dilakukan pada bulan ini setiap Senin, Selasa, Kamis, Sabtu.
RTL	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervisi berkala di area TPS B3. • Koordinasi dengan CS untuk membersihkan bagian yang kotor dan melaporkan pada bagian IPSRS untuk menutup kembali papan penutup kabel supaya terlihat lebih rapi. • Sering mengingatkan lagi petugas CS untuk tetap menyalakan exhaust fan agar tidak beresiko pengap atau bau di TPS B3. • Pertahankan pencatatan limbah yang sudah berjalan dengan baik.

4.1.7 Penanganan dan Pengiriman Sampah Di Ruang.
Gambar 4.1.7 Grafik capaian penanganan dan pengiriman sampah di ruangan RS Prima Husada.

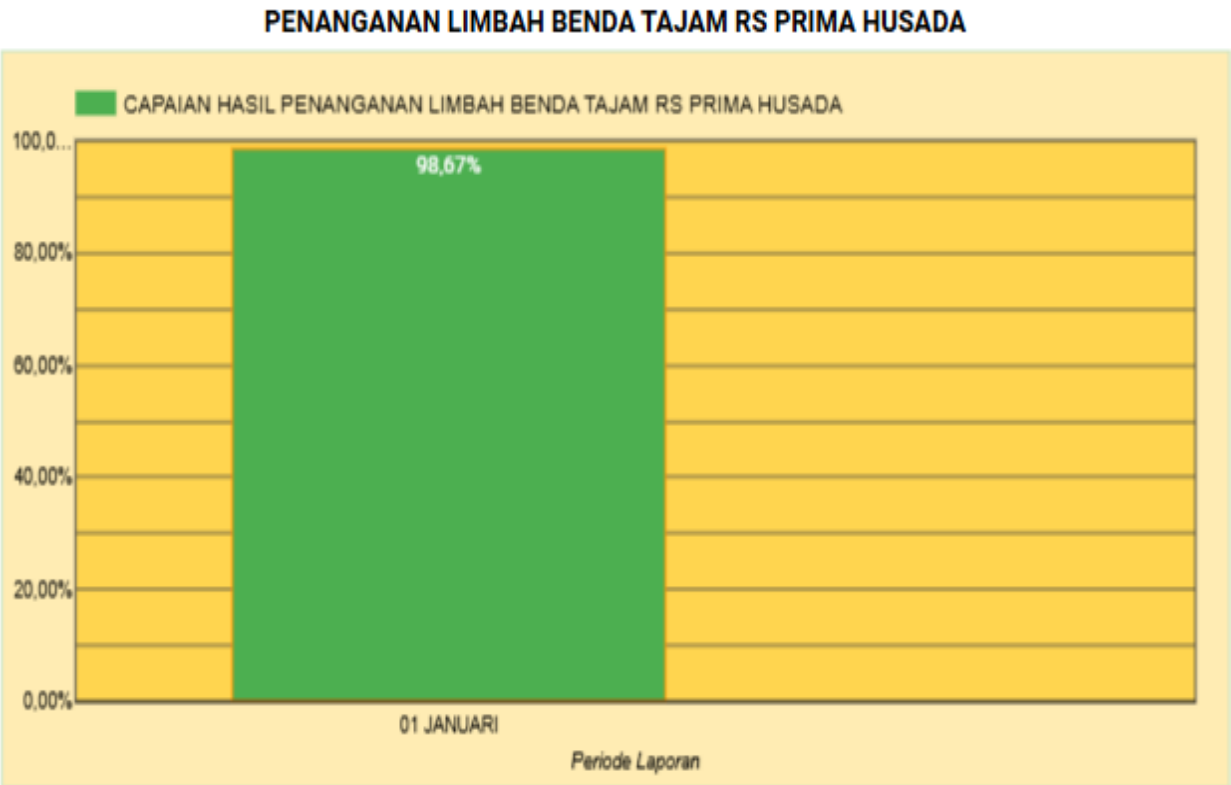


Kegiatan Pokok	Penanganan dan pengambilan sampah di ruangan (infeksius dan non infeksius).
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	- Prosentase penanganan dan pengambilan sampah di ruangan secara keseluruhan yaitu 98,40%. - Ditemukan 3 tempat sampah di area laundry, HCU, dan ponek IGD tidak dapat berfungsi pijakannya karena pengaitnya lepas.

	• Ditemukan 1x tempat sampah lupa belum diberi kresek hitam baru setelah diambil di CSSD. • Ditemukan 16x saat supervisi, temuan terbanyak ada pada kesalahan pemilahan sampah dimana unit-unit masih sering salah membuang sampah bungkus spuit, bungkus alcohol swab, bungkus infus set di tempat sampah infeksius maupun di safety box, seharusnya dibuang dipilah saat tindakan di sampah non infeksius. • Dari hasil supervisi, petugas sebenarnya paham terkait pemilahan sampah, namun malas untuk melakukan pemilahan di awal/pada saat melakukan tindakan meskipun sudah diingatkan.
RTL	• Tingkatkan capaian dan tetap lakukan supervise pemilahan dan pembuangan sampah di unit pelayanan, menegur langsung petugas jika ditemukan kesalahan pembuangan sampah. • Koordinasi dengan coordinator CS terkait perbaikan tempat sampah yang tidak berfungsi baik, dan apabila tidak bisa dibetulkan, didata dan diajukan permintaan yang baru. • Melakukan sosialisasi antar staf tentang pemilahan sampah. • Menegur dan meminta petugas yang salah membuang sampah untuk meletakkan sampah pada tempat yang sesuai. • Mengingatkan untuk membawa kresek pengganti saat akan membuang sampah yang ada di tempat sampah.

4.1.8 Penanganan Limbah Benda Tajam

Gambar 4.1.8 Grafik Capaian penanganan limbah benda tajam di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi pembuangan sampah benda tajam.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	Pada Bulan ini, prosentase audit supervise pembuangan sampah benda tajam yaitu 98,67%.

	• Safety box yang digunakan pada unit masih tidak memenuhi standart sehingga tidak ada tutup fleksibel yang mengakibatkan safety box selalu terbuka sehingga tidak safety untuk petugas karena memungkinkan untuk mengambil isi didalamnya. Ditambah lagi petugas masih ditemukan 1x tidak menutup dengan baik bagian mulut safety box sehingga masih terbuka lebar. • Ditemukan 3x safety box di IRNA melebihi $\frac{3}{4}$ bagian karena menunggu CS merakitkan kembali safety boxnya. • Petugas juga masih sering salah membuang sampah bungkus plastik alkes ke safety box.
RTL	• Tingkatkan capaian dan monitoring pembuangan benda tajam berkoordinasi dengan unit dan petugas CS. • Melakukan edukasi dan memberikan contoh pada petugas yang berdinas cara menggantung safety box yang benar. • Mengkonfirmasi kejadian kesalahan pembuangan benda tajam pada Karu untuk ikut mengingatkan kembali anggota unitnya agar tidak terjadi pajanan benda tajam karena kesalahan pembuangan sampah. • Mengingatkan kembali pada petugas untuk segera meminta bantuan CS untuk mengganti safety box baru jika safety box sudah mencapai garis batas yang ditentukan dan merakitnya sesuai anjuran tidak terbuka lebar.

4.1.9 Penyuntikan yang Aman dan Teknik Aseptik

Gambar 4.1.9 Grafik capaian penyuntikan yang aman dan teknik aseptic di RS Prima Husada.

PENYUNTIKAN YANG AMAN & TEKNIK ASEPTIK RS PRIMA HUSADA

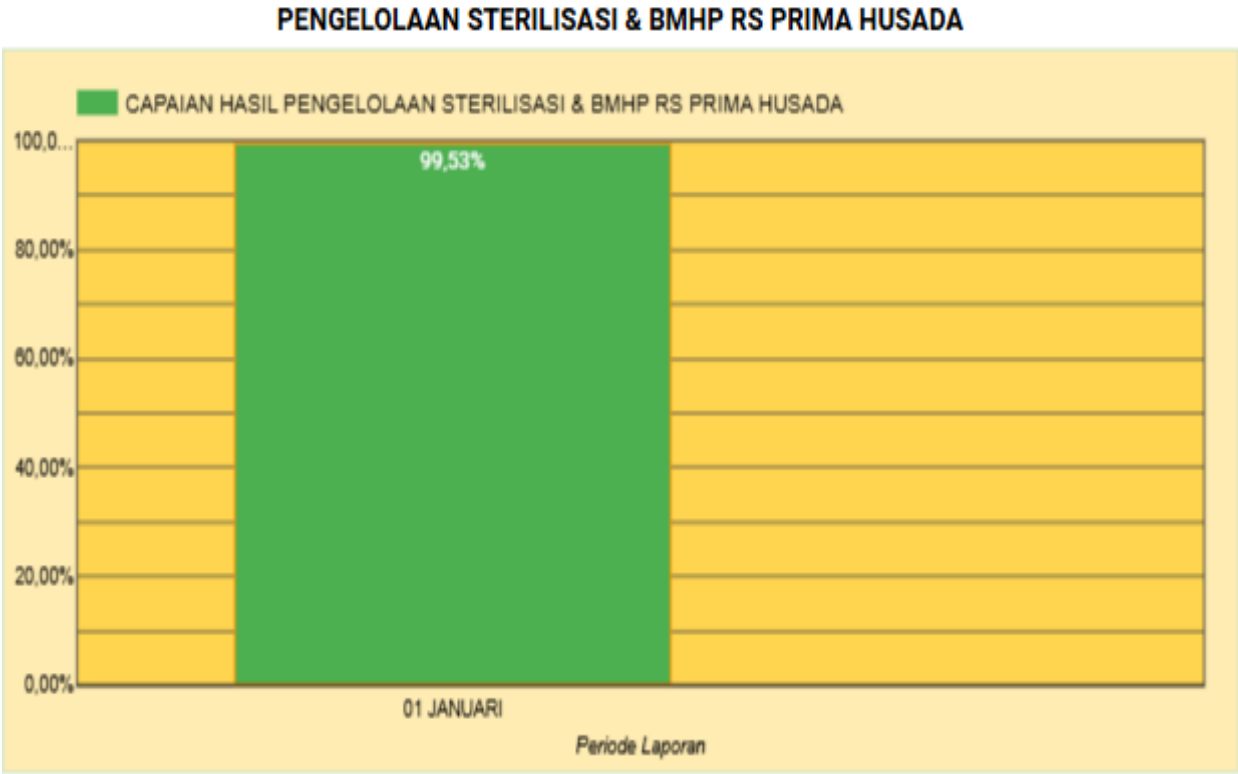


Kegiatan Pokok	Audit supervisi penyuntikan yang aman.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	- Pada Bulan ini, prosentase audit supervise penyuntikan yang aman secara keseluruhan yaitu 99,15%. - Ditemukan jarum yang sudah tidak terbungkus yang masih disimpan ditroli unit (IRNA 8A). - Masih banyak unit yang memakai NS 500 cc untuk media pencampur obat sehingga tidak langsung habis dan disimpan di troli. - Ditemukan bekas ampul dan spuit tidak langsung dibuang setelah dilakukan tindakan di IKO. - Masih ditemukan 2 petugas yang melakukan recapping tutup jarum tidak one hand.

RTL	• Menganjurkan kepada petugas unit untuk tidak menyimpan jarum yang sudah tidak terbungkus karena sudah tidak steril meskipun hanya dipakai untuk mengambil cairan NS untuk mengencerkan obat injeksi karena akan merusak sterilitas cairan. • Membuang jarum yang sudah on agar tidak dipakai kembali. • Menegur petugas yang membiarkan obat multidose / cairan yang tidak menyimpan dengan baik. Share kejadian pada kepala ruang supaya Karu ikut mengontrol unitnya jika menemukan. • Mengingatkan kembali pada petugas untuk segera membuang bekas ampul atau spuit yang sudah tidak dipakai lagi langsung setelah tindakan, tidak menunggu orang lain yang membereskan.
------------	--

4.1.10 Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP

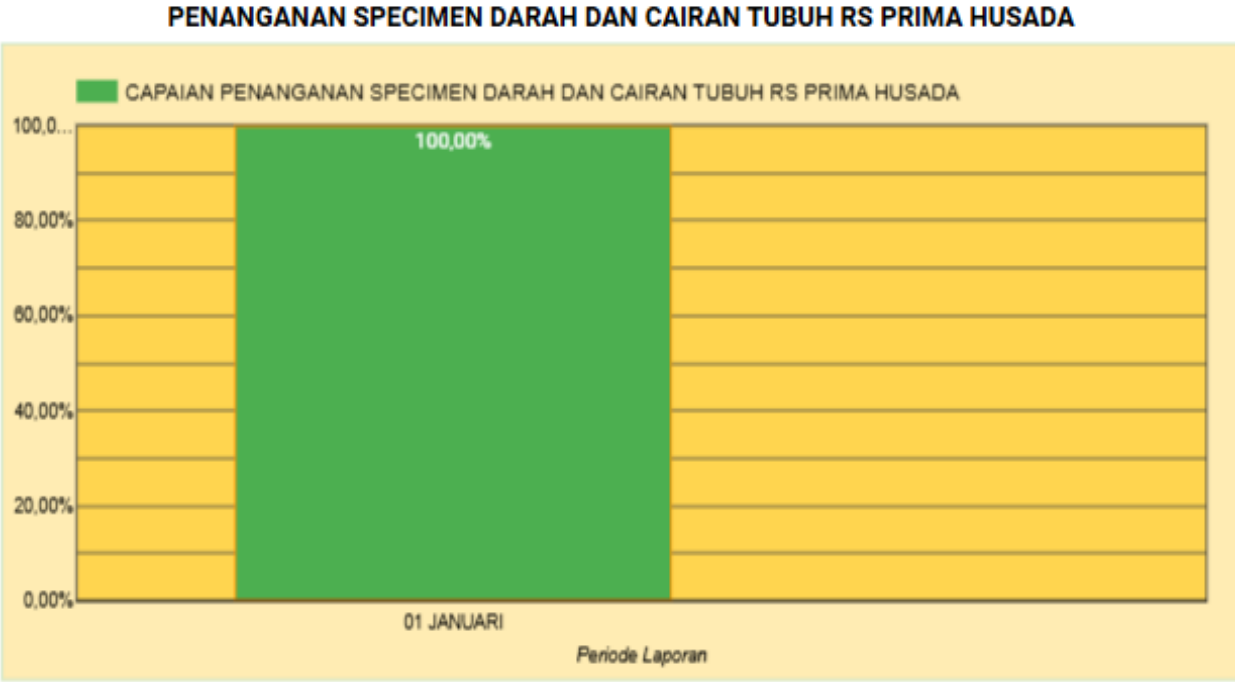
Gambar 4.1.10 Grafik capaian pengelolaan sterilisasi dan BMHP di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi pengelolaan sterilisasi dan BMHP di CSSD.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	Prosentase dekontaminasi dan sterilisasi di CSSD yaitu 99,53%.

	• Evaluasi kertas indikator dari vendor bagian eksternal di CSSD masih tidak berubah warna setelah dilakukan sterilisasi di mesin memet dengan suhu dan lama waktu sebelumnya. Namun dapat berubah saat dilakukan perubahan lama waktu dan suhu penyeterilan selama 1 jam dengan suhu 160 derajat, stiker berubah warna namun sebagian pouches pembungkus lengket karena terlalu panas. • Sudah dilakukan uji swab alat kesehatan untuk memastikan kualitas proses penyeterilan selagi kertas indikator bermasalah.
RTL	• Tingkatkan capaian dan melakukan koordinasi dengan Karu unit pelayanan untuk menjalankan pelayanan CSSD sesuai standar. • Lakukan koordinasi dengan CSSD, bagian pengadaan, dan vendor pihak 3 penyedia kertas indikator untuk melakukan evaluasi uji coba kertas indikator yang dapat berubah warna seperti yang sebelumnya di mesin memert.

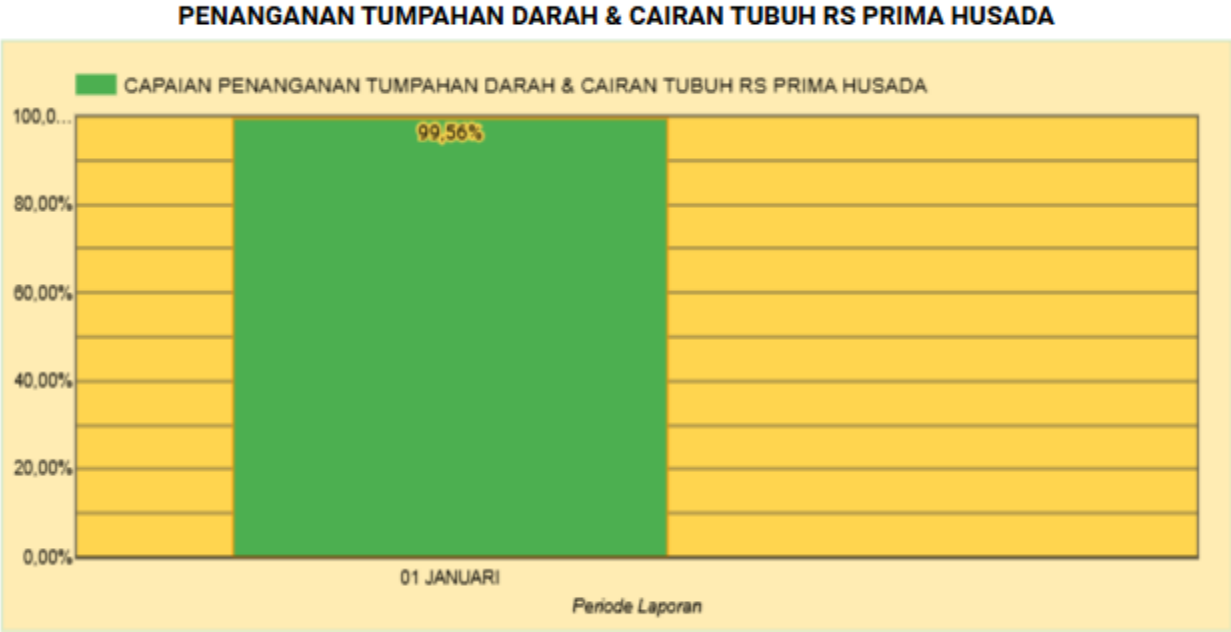
4.1.11 Penanganan Specimen Darah dan Cairan Tubuh
Gambar 4.1.11 Grafik capaian penanganan specimen darah dan cairan tubuh di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit supervisi penanganan specimen darah dan cairan tubuh.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Prosentase kepatuhan penanganan specimen darah dan cairan tubuh secara keseluruhan sudah mencapai 100%. • Petugas unit tertib melakukan penanganan specimen untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
RTL	• Pertahankan pelayanan dan tingkatkan supervise terkait penanganan specimen pemeriksaan. • Tetap lakukan monitoring pada penggunaan box lab untuk membawa specimen darah atau cairan tubuh lainnya..

4.1.12 Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh

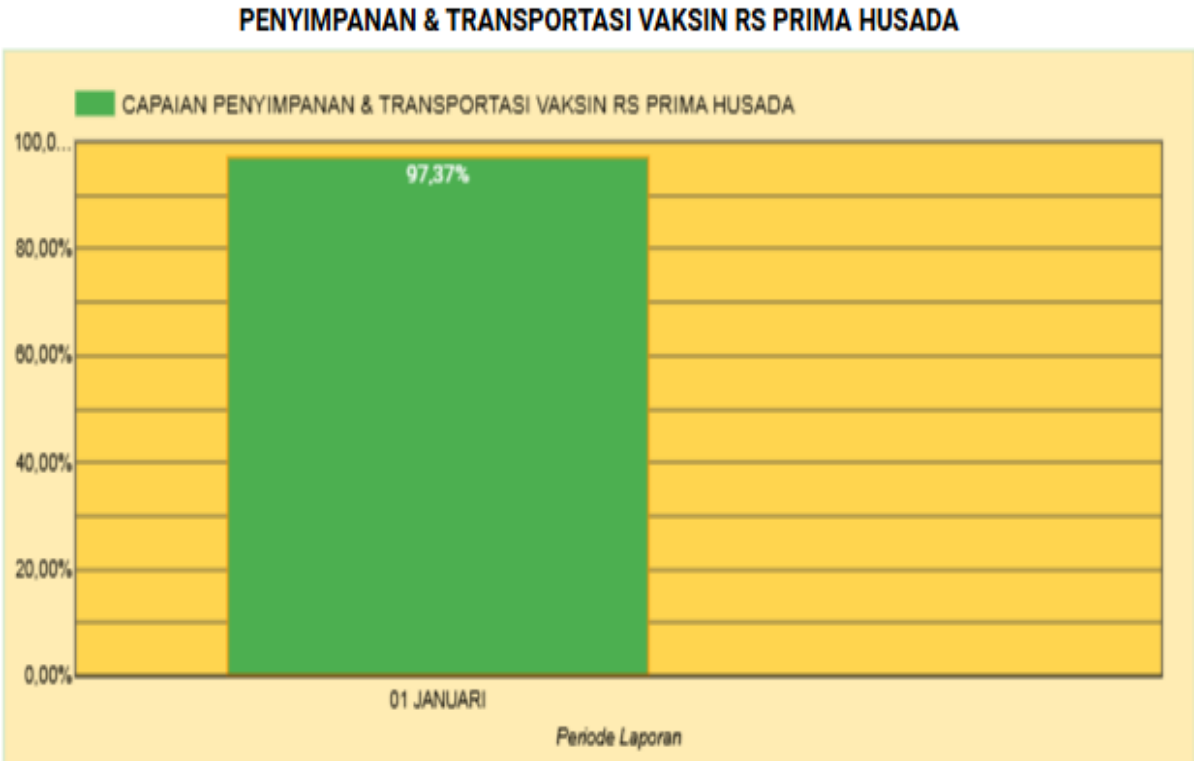
Gambar 4.1.12 Grafik capaian penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Pengendalian tumpahan darah dan cairan tubuh keseluruhan prosentasenya 99,56%. • Ditemukan tidak ada ketidakpatuhan penggunaan spill kit dari 12 temuan tumpahan pada bulan ini dimana 9 diantaranya tumpahan/ceceran darah dan 3 diantaranya muntahan. • Masih ditemukan isi spill kit yang tidak lengkap sesuai dengan isi update box spill kit terutama isi bahan penyerap seperti under pad dan tissue serta APD masker dan sarung tangan yang lupa tidak diisi ulang langsung setelah dipakai di IRNA 6A dan 8A. • Masih banyak petugas yang tidak urut dalam pemakaian spill kit.
RTL	• Tingkatkan supervise di unit, dan ajak kepala unit untuk melihat ketidak patuhan yang terjadi di unitnya dan agar segera menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut. • Mengingatkan petugas terkait dan menyampaikan kepada kepala ruang terkait ketidaksesuaian dengan standar. • Mengingatkan kembali terutama petugas CS jika ada tumpahan untuk membiasakan memakai box spill kitnya. • Melakukan resosialisasi pada saat briefing CS untuk membantu mengingat urutan pemakaian spill kit yang benar. • Mengkonfirmasi kekurangan isi box spill kit pada Karu dan CS unitnya sesuai dengan update data terbaru.

4.1.13 Penyimpanan dan Transportasi Vaksin

Gambar 4.1.13 Grafik capaian penyimpanan dan transportasi vaksin di RS Prima Husada

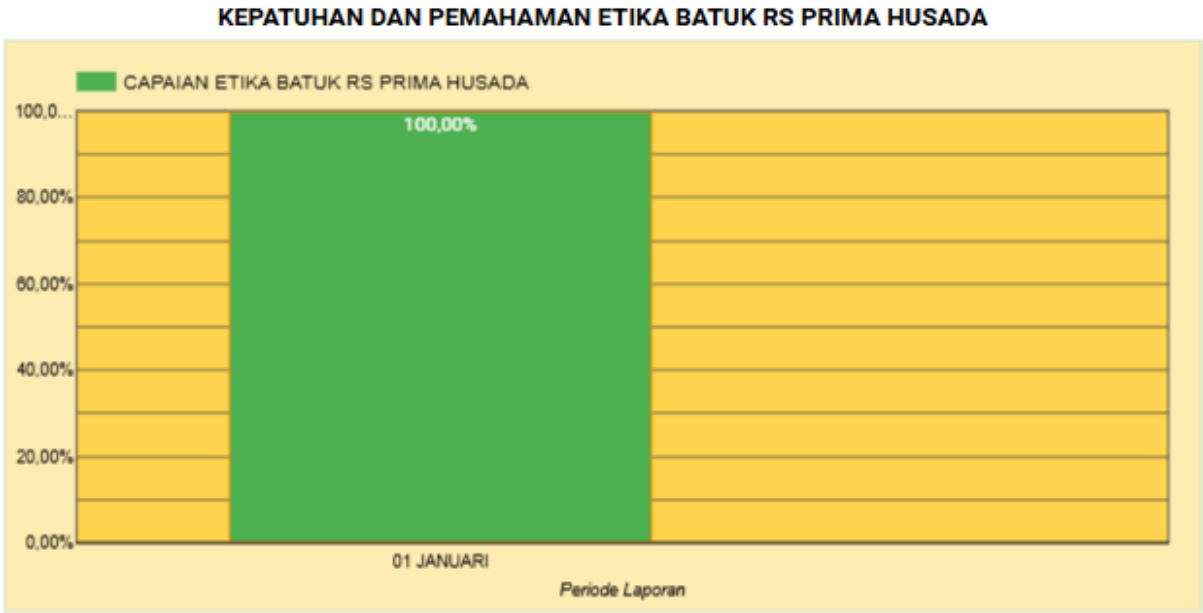


Kegiatan Pokok	Audit supervisi penyimpanan dan transportasi vaksin.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	- Prosentase penyimpanan dan transportasi vaksin mencapai 97,37%. - Masih ditemukan ketidaktertiban pengisian suhu lemari pendingin. Kepatuhan pengisian petugas mulai menurun kembali untuk petugas Gudang farmasi, namun untuk pencatatan di depo farmasi sudah dilakukan secara rutin.

RTL	• Tingkatkan capaian dan lanjutkan melakukan audit penyimpanan dan transportasi vaksin. • Dibagi tugas dan tanggungjawab antara apoteker gudang farmasi dan depo farmasi terkait pencatatan suhu lemari pendingin. • Koordinasi dengan Ka Instalasi Farmasi untuk juga membantu mengontrol pencatatan suhu penyimpanan vaksin karena jika suhunya tidak terkontrol bisa merusak vaksin.
------------	---

4.1.14 Etika Batuk

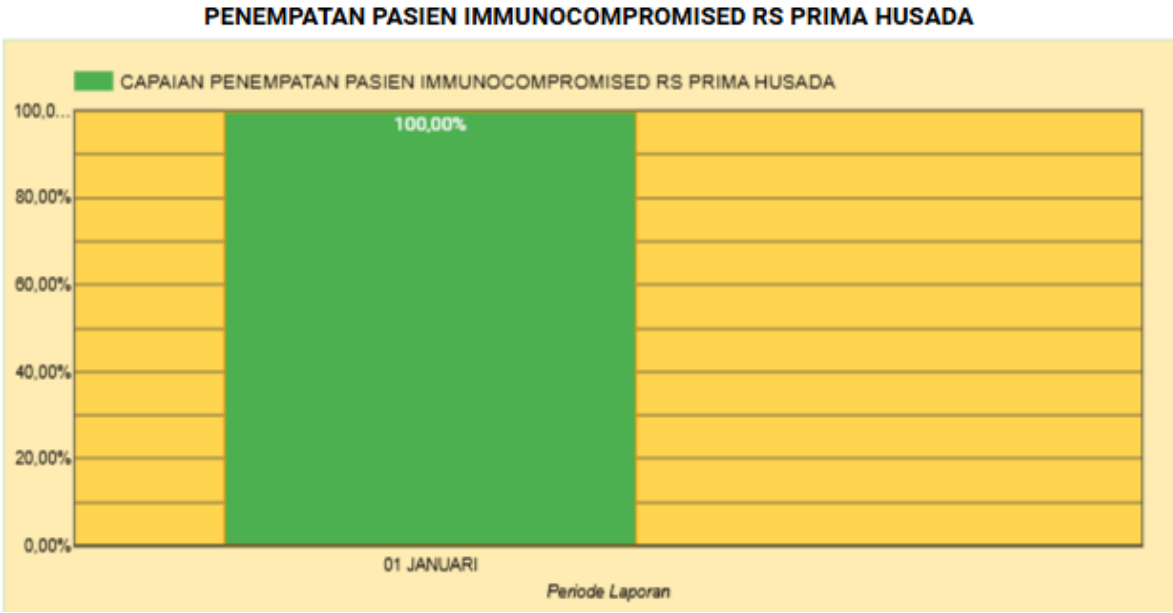
Gambar 4.1.14 Grafik capaian Etika batuk di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Monitoring supervisi etika batuk.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut

Hasil Analisa	• Prosentase etika batuk petugas di RS Prima Husada sebanyak 100%. • Petugas paham dan mengerti etika batuk yang benar saat ditanya & mempraktekkan dengan benar.
RTL	• Pertahankan capaian dan lanjutkan melakukan monitoring etika batuk petugas yang benar. • Mengingatkan kembali petugas tersebut untuk melakukan etika batuk dengan benar.

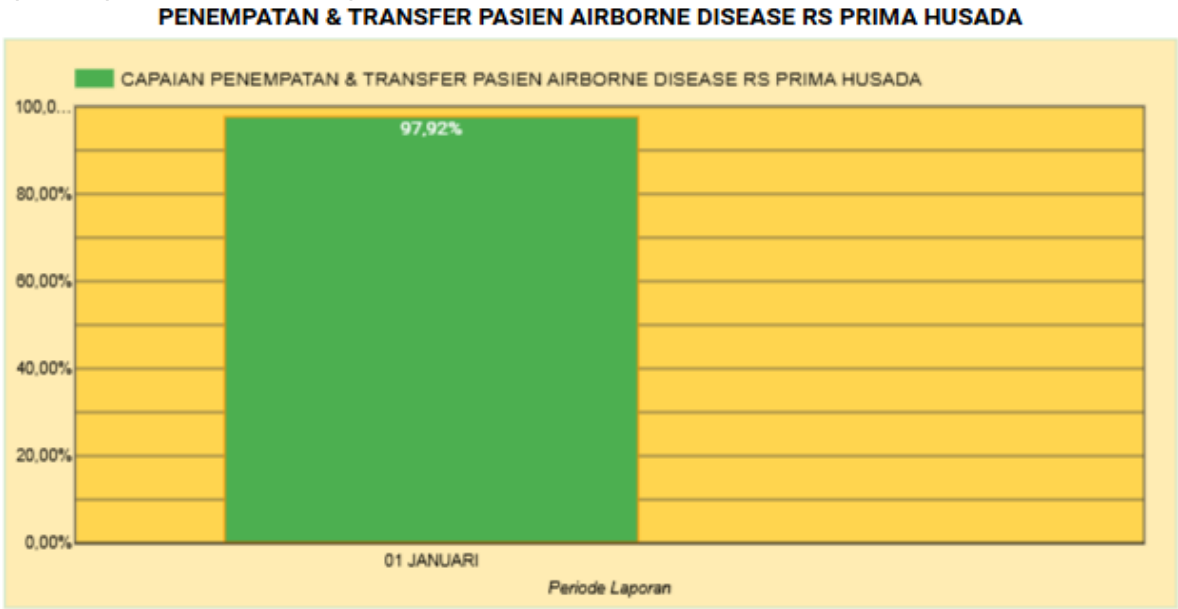
4.1.15Penempatan Pasien Immunocompromised
 Gambar 4.1.15 Grafik capaian penempatan pasien immunocompromised



Kegiatan Pokok	Monitoring supervisi penempatan pasien immunocompromised.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut

Hasil Analisa	• Penempatan pasien immunocompromised dilakukan dengan menggunakan system kohorting, prosentasenya mencapai 100%, pasien dikohorting di ruangan immunocompromise di ruang IRNA 2C dan IRNA 4B. Jika kosong ruangan digunakan untuk pasien biasa.
RTL	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervisi pada unit-unit terutama IRNA terkait penempatan pasien sesuai dengan diagnosis penyakitnya.

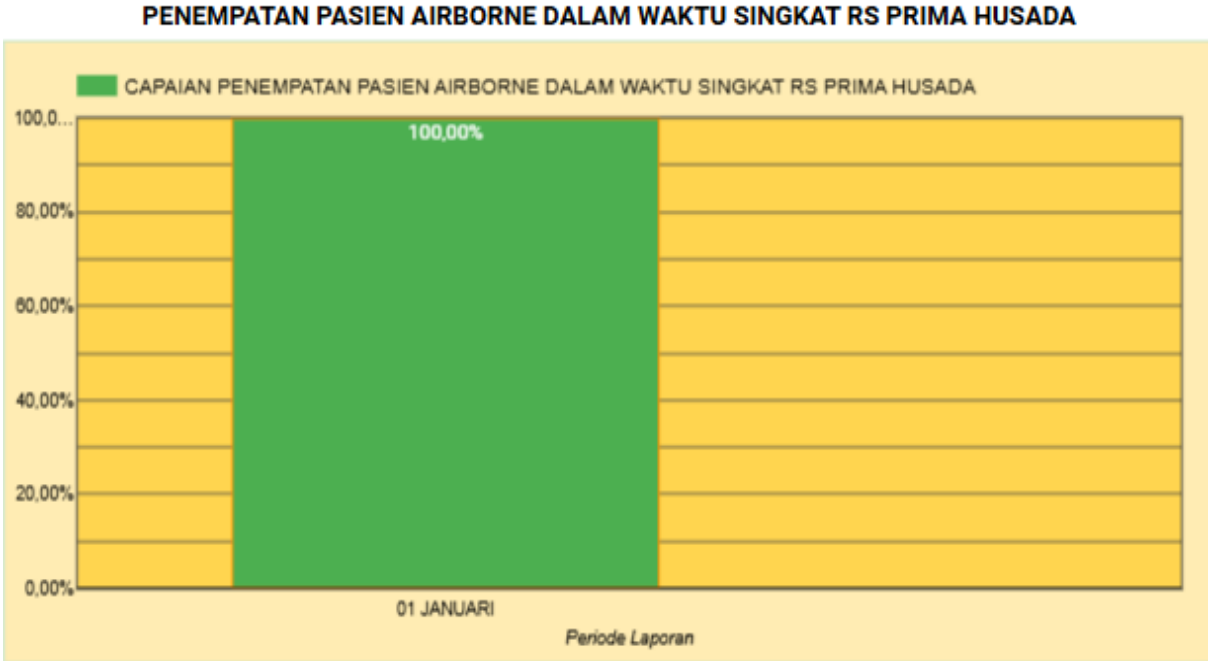
4.1.16 Penempatan dan Transfer Pasien Airborne Disease
Gambar 4.1.16 Grafik capaian penempatan dan transfer pasien airborne disease di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Audit Supervise penempatan dan transfer pasien infeksi airborne.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut

Hasil Analisa	• Prosentase penempatan dan transfer pasien infeksi airborne pada bulan ini mencapai 97,92%. Penempatan pasien airborne di rawat inap sudah ditempatkan di ruang isolasi/kohorting dengan ventilasi yang memadai dan beberapa pasien yang curiga/suspect ditempatkan secara kohorting di beberapa ruang di IRNA yang memiliki ventilasi cukup. • Namun ketertiban penggunaan masker dan peletakkan masker N95 yang digunakan perlu ditertibkan karena petugas masih ada yang menaruhnya tidak di anteroom.
RTL	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervise pada unit-unit rawat inap dan ruang isolasi terkait penempatan pasien sesuai dengan diagnosis penyakitnya dan audit transfer pasien isolasi sesuai prosedur. • Lakukan edukasi kembali terkait pemakaian dan penanganan masker yang telah digunakan.

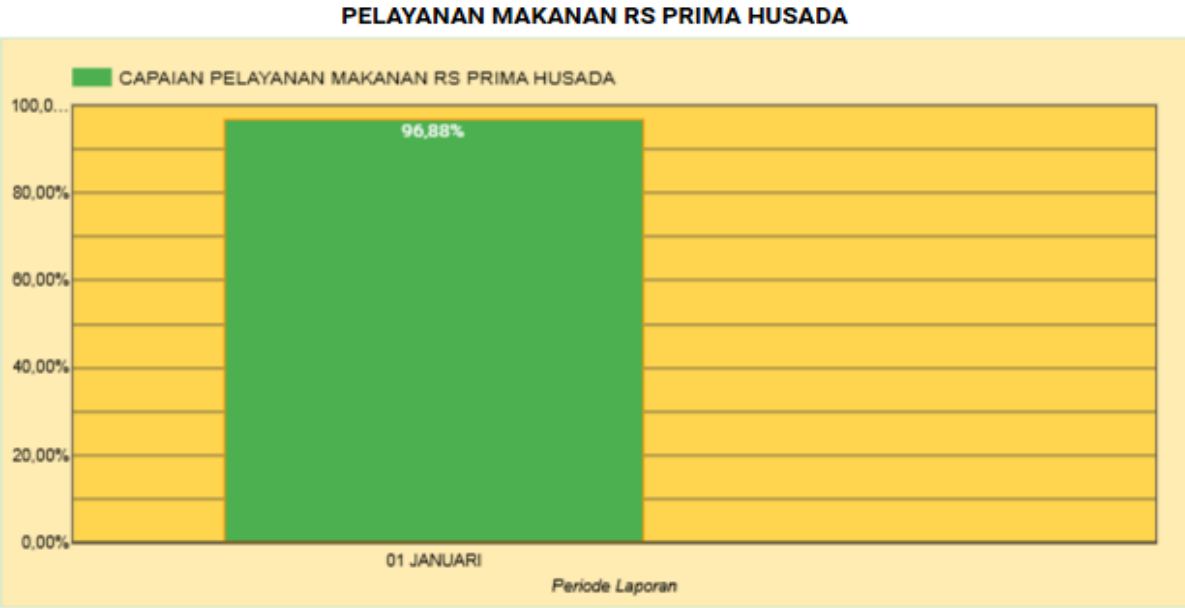
4.1.17 Penempatan Pasien Airborne dalam Waktu Singkat
Gambar 4.1.17 Grafik capaian penempatan pasien airborne dalam waktu singkat di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Monitoring penempatan pasien infeksi airborne dalam waktu singkat.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Penempatan pasien airborne disease di IGD sudah ditempatkan di isolasi IGD dengan baik prosentasenya 100%.
RTL	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit pada unit-unit terutama IGD dan ruang pasien terkait penempatan pasien sesuai dengan diagnosis penyakitnya.

4.1.18Pelayanan Makanan

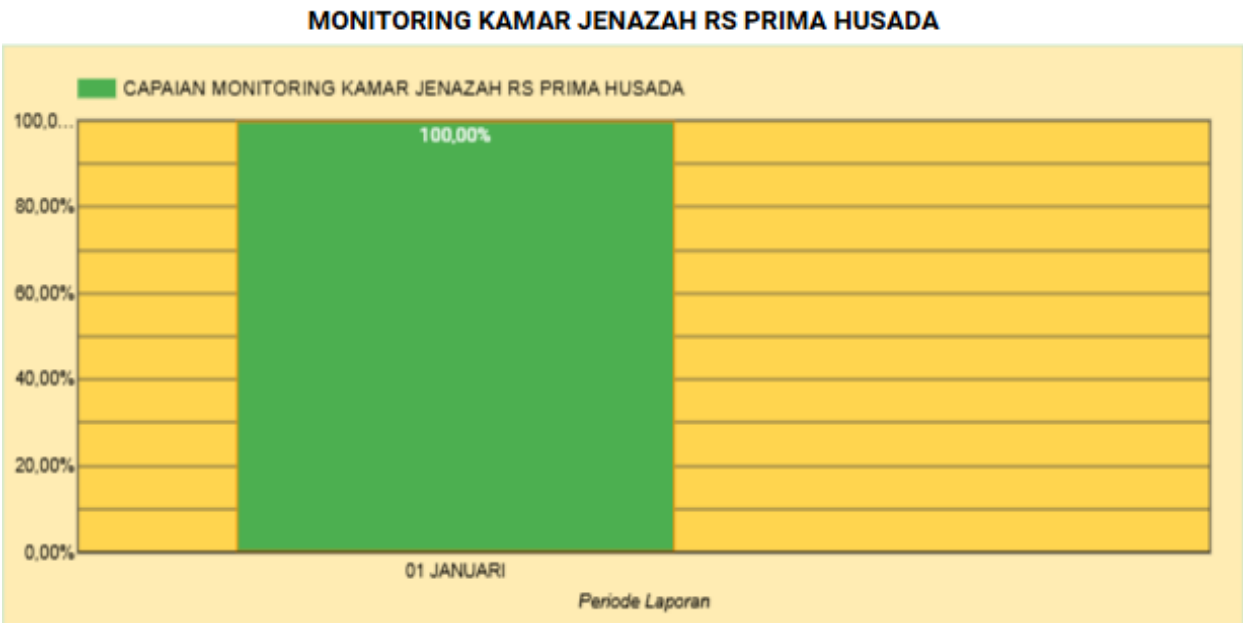
Gambar 4.1.18 Grafik capaian pelayanan makanan di RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Monitoring supervisi pelayanan makanan.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Pada Bulan ini, prosentase audit supervise pelayanan makanan yaitu 96,88%. • Kebersihan ruang dapur masih kurang, ditemukan serangga kecil diarea lantai tempat pencucian alat masak dapur. • Penggunaan APD petugas terutama hand gloves dan masker sudah baik pada petugas penyaji makanan pada bulan ini, APD masker sudah lebih tertib digunakan meskipun ada yang masih memakainya tidak benar. • Masih ditemukan tirai PVC yang disingkap di dekat gudang kering.
RTL	• Tingkatkan capaian dan monitoring pelayanan makanan. • Selalu ingatkan petugas untuk menjaga kebersihan di dapur, terutama pada saat memasak dan menyiapkan makanan agar bisa lebih rapi lagi. • Tertibkan petugas yang menyingkap tirai PVC agar tidak melakukan kembali, karena beresiko serangga masuk. • Evaluasi berkala terdapat peningkatan kesadaran petugas terhadap kepatuhan pemakaian APD. • Mengingatkan kembali petugas untuk membersihkan langsung sink wastafel setelah digunakan dan koordinasi dengan CS pantry untuk pembersihan permukaan setelahnya rutin sampai ke celah-celah sempit.

4.1.19Monitoring Kamar Jenazah

Gambar 4.1.19 Grafik capaian monitoring kamar jenazah di RS Prima Husada

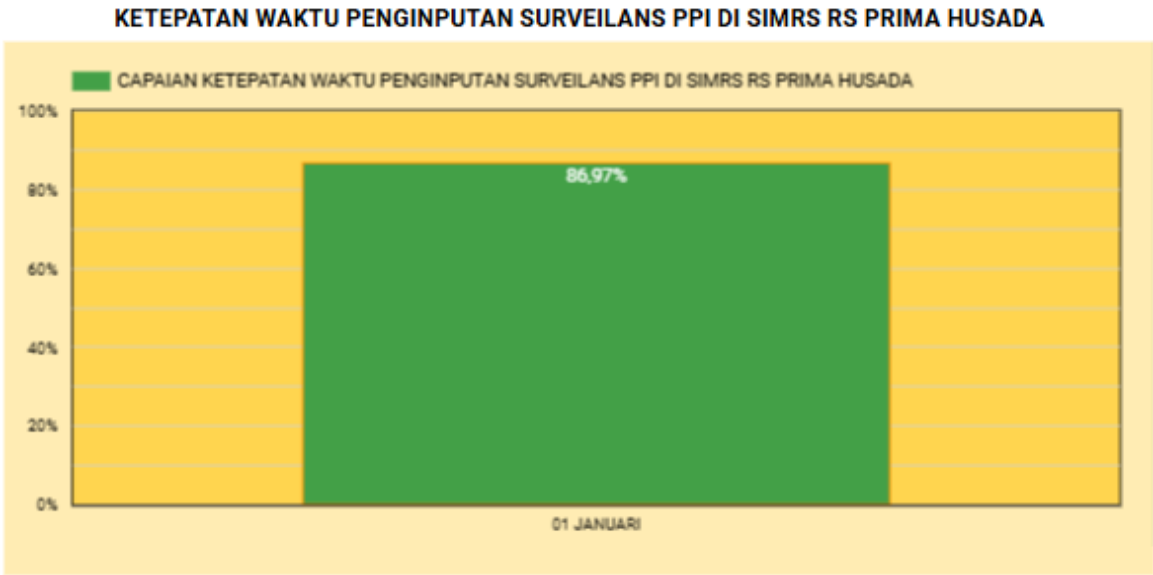


Kegiatan Pokok	Monitoring supervisi kamar jenazah.
Rincian Kegiatan	• Membuat jadwal pelaksanaan audit • Melakukan audit di setiap ruangan • Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	• Pada Bulan ini, prosentase audit kamar jenazah yaitu 100%. Kebersihan dan kelembapan ruangan rutin dijaga oleh petugas penanggung jawab.
RTL	• Tingkatkan capaian dan tetap lakukan supervisi di kamar jenazah. • Koordinasi dengan petugas kamar jenazah untuk rutin membuka kamar jenazah setiap pagi selama beberapa waktu kemudian dibersihkan dan ditutup kembali, supaya tidak lembab.

	Pencatatan akan dibantu share oleh perawat unit dan driver pada saat akan pengantaran jenazah melalui grup WA.
--	--

4.1.20 Kelengkapan Inputan Surveilans PPI Di SIMRS

Gambar 4.1.20 Grafik capaian kelengkapan inputan surveilans PPI di SIMRS RS Prima Husada



Kegiatan Pokok	Monitoring supervisi kelengkapan penginputan surveilans PPI di SIMRS.
Rincian Kegiatan	- Membuat jadwal pelaksanaan audit - Melakukan audit di setiap ruangan - Menganalisa hasil audit dan membuat rencana tindak lanjut
Hasil Analisa	Grafik menunjukkan capaian ketepatan waktu penginputan surveilans PPI dari Januari 2026 berada pada 86,97%. Secara umum, capaian relatif baik tetapi belum mencapai standar ideal $\geq 90\%$. Dimana unit yang sering tidak tepat waktu melakukan inputan dengan rata-rata prosentase dibawah 75% yaitu IRNA 6A, IRNA 7A, IFRS, IGD, IKO. Sudah berkurang dari bulan lalu, hal ini berarti terdapat peningkatan kepatuhan penginputan data dari unit lainnya.

RTL	• Tingkatkan capaian dan tetap lakukan supervisi setiap hari. • Monitoring capaian mingguan oleh tim PPI: siapa yang sudah input dan belum. • Feedback tertulis bulanan kepada unit melalui website ppi tampilan grafik capaian. • Rekapitulasi dan publikasi capaian per unit melalui grup WA atau grup mutu. • Pendampingan onsite untuk unit yang capaian rendah. • Koordinasi juga dengan Karu untuk ikut memonitoring penginputan setiap harinya agar petugas unit menjadi lebih tertib. • Koordinasi dengan tim pmkp untuk membantu penginputan data saat IPCLN tidak bertugas.
------------	---

4.2 Evaluasi Jadwal (Time Scedule)

[illegible]

No	KEGIATAN	Januari 2026																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	b. Vaksinasi karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. MCU seluruh karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pemeriksaan rectal swab petugas gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Monitoring Mutu	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Surveilans	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Audit program PPI	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pemeriksaan fisika & biologi air bersih dan air minum	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a. Rapat bulanan PPI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	b. Koordinasi dengan manajemen. (Morning Report)	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[illegible]

I. PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan kembali kegiatan monitoring supervisi baik dari IPCN maupun koordinasi dari IPCLN dan kepala ruang masing-masing untuk membantu meningkatkan mutu terutama terkait pencegahan infeksi. Adanya monitoring secara berkala dari kepala unit maupun jajaran manajemen di atasnya dapat meningkatkan kepatuhan dari petugas.

Dilaporkan Kepada,
Ketua Komite PPI



dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 03 Februari 2026
Penyusun,
IPCN



Sherly Rosita, S. Kep. Ns

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

